


پیام نوریها

public channel

✅کانال پیام نوریها در سال 95 با هدف تهیه جزوات و نمونه سوالات افتتاح و از همان ابتدای تاسیس کوشیده است با تکیه بر تلاش بی وقفه ، کارگروهی و فعالیت های بدون چشمداشت کاربران متمایز خود ، قدمی کوچک در راه پیشرفت ارائه خدمات به دانشجویان این مرز و بوم بردارد.

@Payamnoria

telegram.me/Payamnoria

رایگان است و همیشه رایگان میماند




اطلاع از اخبار و دانلود جزوات و نمونه سوالات

برای ورود به کانال تلگرامی پیام نوریها کلیک کنید

# " کانال و خانواده تلگرامی پیام نوریها "

**با عضویت در کانال و به آرشیو زیر دسترسی پیدا کنید**

**✓ تمام نمونه سوالات به روز تا آخرین دوره**

**✓ جزوات درسی**

**✓ بیش از ۱۰۰ فلش کارت دروس**

**✓ اخبار به روز پیام نور**

**✓ فیلم و فایل آموشی اختصاصی**

**✓ انجام انتخاب واحد و حذف و اضافه**

**✓ پاسخگویی به سوالات دانشجویان**

**✓ معرفی گروه و انجمن های پیام نوری**

**✓ طنز و توییت دانشجویی**

**به یکی از بزرگترین کانال های پیام نوری بپیوندید**

## برای ورود به کانال تلگرامی پیام نوریها کلیک کنید

**" با سلام خدمت شما دوستان گرامی "**

تمام کتب موجود در کانال پیام نوریها از سراسر اینترنت که به صورت رایگان قرار گرفته است جمع آوری شده و اینک در اختیار شما دانشجویان عزیز می باشد

موفق و پیروز باشید ☺

**" کانال و خوانواده تلگرامی پیام نوریها "**

**@Payamnoria**


بسم الله الرحمن الرحيم

هر چه از عمر مي گذرد ، بيشتر مطمئن مي شوم كه تفاوت اصلي ميان افراد ، بين ضعيف و قوي ، بين مهم و بي اهميت ، انرژي – يا عزم و اراده راسخ – است ، مفهومي كه معين شده و بعد از آن مرگ يا پيروزي است .

دانشگاه پيام نور
مركز بيرجند

# اسلايد آموزشي درس روانشناسي سلامت

اثر : آنتوني جي . كُرتيس

مترجمان : دكتر علي فتحي آشتياني – هادي عظيمي آشتياني

استاد :
جناب آقاي فريدون رمضاني

تابستان 85

فصل اول :

# مقدمه اي بر روانشناسي سلامت

سلامت :

حالت خوب بودن كامل، از نظر جسمي- رواني و اجتماعي است ، و اين به معناي فقدان بيماري و ناتواني نيست .

( اساسنامه سازمان بهداشت جهاني 1946 )

سلامت واقعي = پيشگيري از بيمار شدن + ارتقاي سلامت مثبت

نگاه تاريخي به سلامت وبيماري :

قرن17 تا اوايل قرن 20←1)بيمار شدن اتفاقي ناگهاني است كه نمي توان ازآن ايمن بود.
علت عمده مرگ ←بيماريهاي عفوني « حاد » ( حملات ناگهاني ) مثل آنفولانزا ، ذات الريه وسل .
2) بيماري ←كار نيروهاي شيطاني يا دخالت خدايان .
3) امروزه بيماري هاي مزمن ( شروع تدريجي و مدت طولاني ) مثل سرطان ، ناخوشي هاي زندگي ناميده مي شوند . بهبود نمي يابند اما بايد معالجه شوند .

## تكنولوژي پزشكي :

واكسيناسيون و دارو درماني ←—— كاهش بيماري هاي عفوني مثل سرخجه.

آنتي بيوتيك ها ←—— كاهش ابتلا و شيوع ذات الريه و آنفولانزا

## نظريه الگوي زيستي پزشكي :

رابطه بين عامل بيماري زاي خاص(عضو عامل بيماري) و بيماري جسمي .

## الگوي زيستي پزشكي :

- ☑ دوگانه نگري مكتب دكارت ( قرن17 )
- ☑ رنه دكارت : تفاوت ماهيت ذهن و بدن
- ☑ جايگاه روح ← غده صنوبري واقع در مغز ( حيوانات فاقد اين روح )
- ☑ پزشكي جديد غرب ← دوگانه نگر نيست ← در عوض كاملا ريشه در فلسفه وحدت گرا ( مادي گرا ) دارد .

## نظريه اخلاط بيماري :

- ☑ اولين بار توسط بقراط در قرن چهارم قبل از ميلاد در يونان مطرح شد .
- ☑ در حدود 500 سال بعد توسط جالينوس بسط داده شد .
- ☑ عوامل بدني ←—— الگوي پزشكي
- ☑ عوامل ذهني ←—— الگوي زيستي ، رواني ، اجتماعي

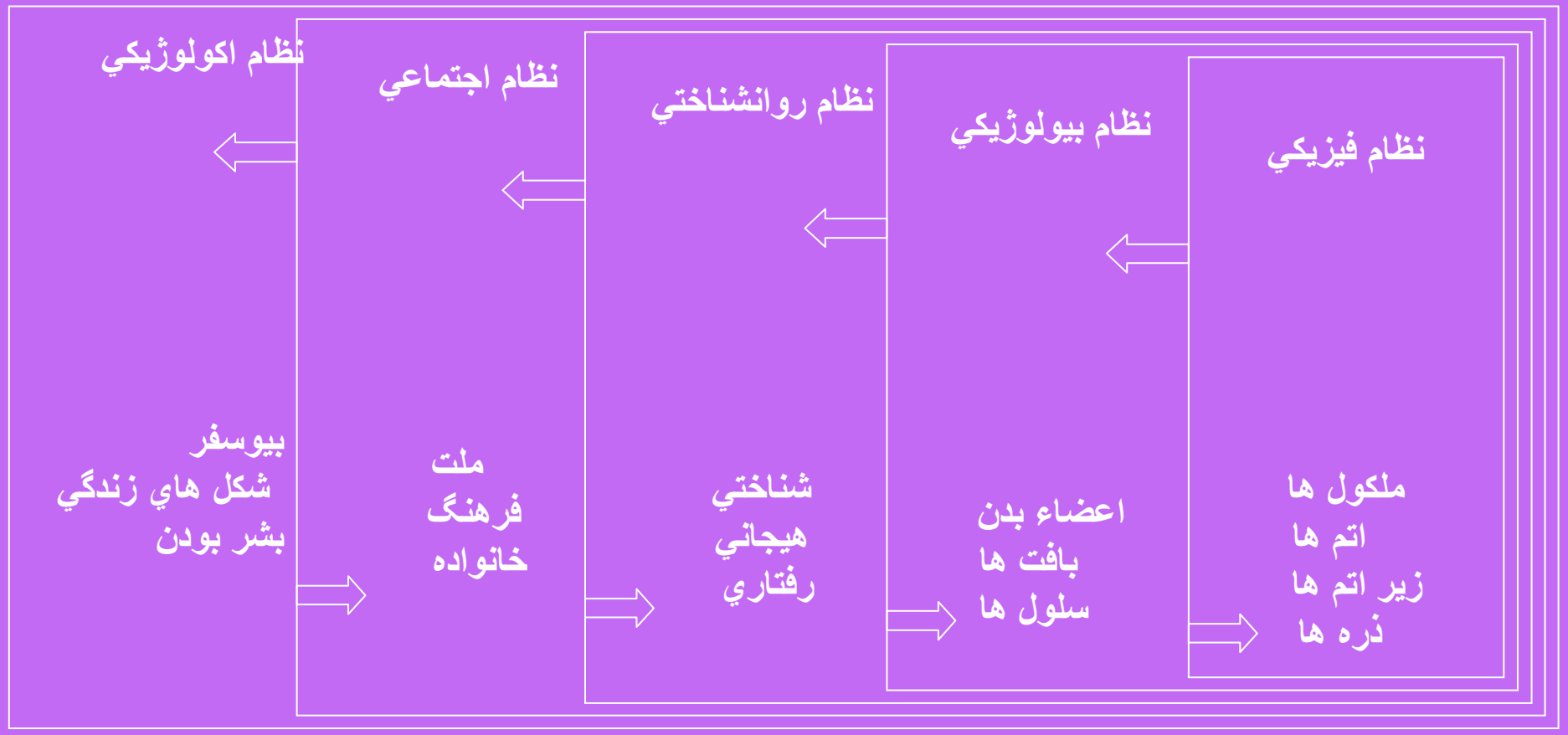
# ارزيابي و نقد الگوي زيستي پزشكي

- تقليل دادن علت بيماري به علل زيستي
- كل نگري : توجه به تماميت فرد در درمان ، نه صرفا بخش بيمار بدن

-توجه به علل جسمي اختلالات جسمي

- تأكيد فوق العاده روي بدن در مقابل ذهن

◈ الگوي زيستي ، رواني ، اجتماعي مبتني بر يك رويكرد نظامدار




الگوي زيستي – رواني – اجتماعي
منبع : پي . بن يارد 1996

توماس مك كئـون ( 1979 ) :

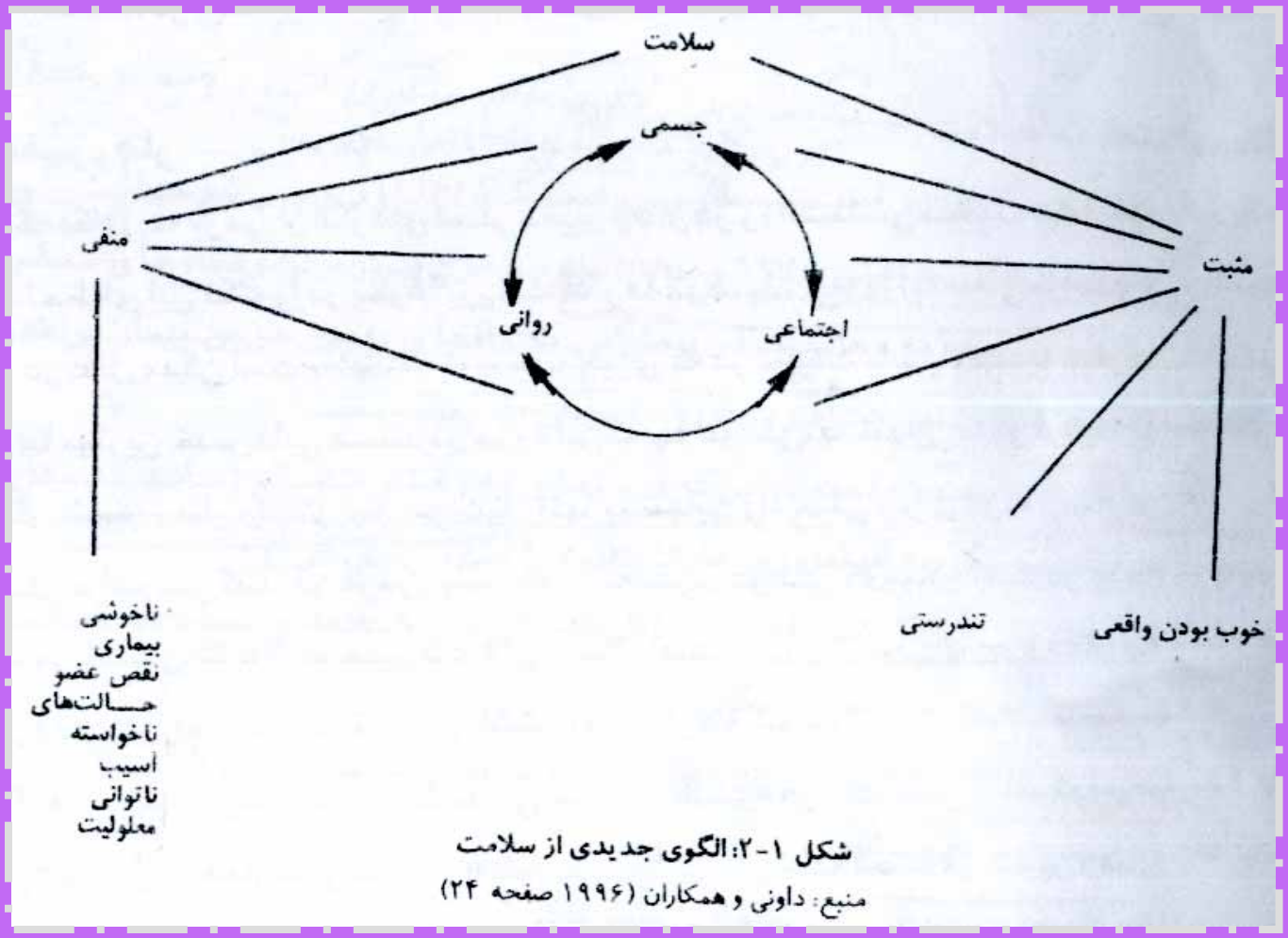
☑ تاثير عوامل اجتماعي و محيطي بر سلامت
☑ نقش دارو بر سلامت از قرن 17

علل شيوع بيماريهاي عفوني از زمان انقلاب كشاورزي اول
- ناكافي بودن غذا
- خطرهاي محيطي
- افزايش جمعيت

علل كاهش بيماريهاي عفوني
- تغذيه و بهداشت بهتر
- كنترل جمعيت

# الگوي جديدي از سلامت :

## داوني و همكارانش (1996) در نظر گرفتن سلامت به عنوان يك مفهوم نسبي به جاي مفهوم مطلق




شکل ۱-۲: الگوی جدیدی از سلامت

منبع: داونی و همکاران (۱۹۹۶ صفحه ۲۴)

خوب بودن واقعي ← به جاي خوب بودن ذهني

سلامت مثبت ← انديشه تندرستي (داوني و همكارانش ، 1996 )

صفات جسمي سلامت ← قدرت، توان، انعطاف پذيري، مهارت

◈ تندرستي ابزاري براي رسيدن به هدف (سلامت مثبت) نه خود هدف

- ارتقاء سلامت مثبت و استفاده از « ارتقاي سلامت » به عنوان وسيله اي براي دستيابي به افزايش هماهنگي سلامت مثبت جسمي ، رواني و اجتماعي ، همراه با پيشگيري از بيماريهاي فيزيكي ، رواني و اجتماعي

## ارزيـابي الـگوي جديـد سلامت :

- ✓ طرح ابعاد مثبت و منفي سلامت و اعتقاد به ارتباط آن با عناصر جسمي رواني و اجتماعي از تعريف سازمان بهداشت جهاني ( 1946 )
- ✓ تقويت نـظريه هماهنـگي عنـاصر سلامت
- ✓ طرح نمونه هايي از شرايط نـاهنجار جسمي ، شـرايط نـاخواسته و يا شرايط ناتوان كننـده

## روانـشناسي و سـلامت :

1- قـرن 20 ←——— نقش روانشناسي در پيشگيري، اداره و ارتقاي سلامت

2- تأسيس « روانشناسي سلامت » بعنوان بخش 38 در APA ( 1978 ) و به تازگي در BPS

3- كمك به شنـاسايي رفتـارها و سبك هاي زندگي فـردي مؤثر بر سلامت جسمي ، پيشگيري و درمان بيماري ، شناسايـي علل خطر زاي مرتبـط با بيماري ، بهبود نظام هاي مراقبت بهداشتي با شناسايي تمرينـهاي خوب و شكل دادن بـه افكار عمـومي در جهت سلامت مـردم .

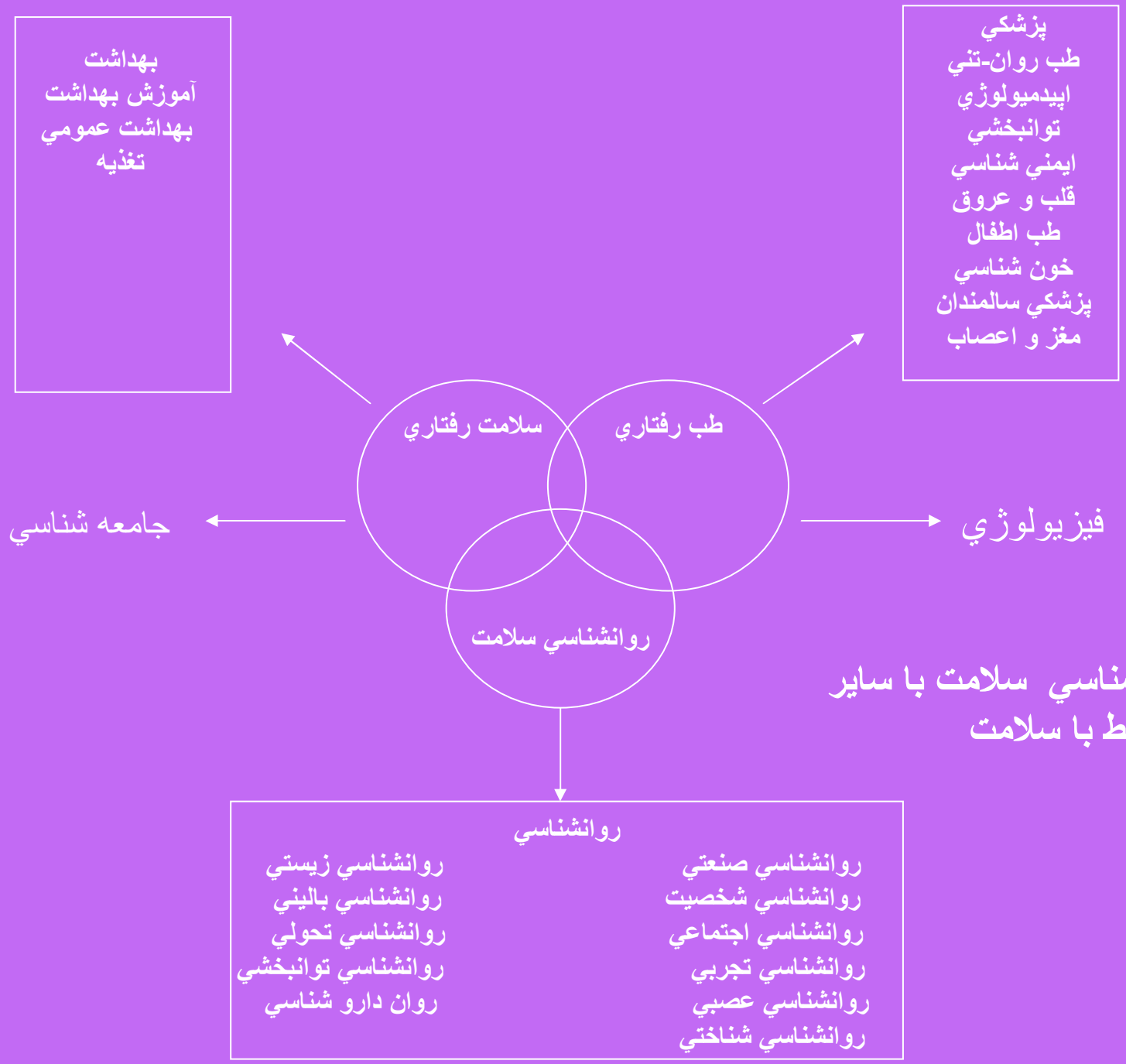
4- به كارگيري اصول روانشناسي در زمينه سلامت ← پايين آوردن فشارخون بالا و مهار سطح كلسترول

5- تأثير روانشناسي سلامت در ← اداره استرس
← تسكين درد
← كاهش و ترك دخانيات
← تعديل ساير رفتارهاي خطرناك ( مثل مصرف الكل )

6- تشويق روانشناسان سلامت در زمينـه ارتقـاي سلامت بـه :

- تمرين هاي منظـم ورزشـي
- معاينـه هاي كامل دندانپـزشكي و پزشكي
- تمرين رفتارهاي سالم تر ( تشويق به رفتارجنسي سالم )

7- همپوشي با بسياري از رشته ها و زمينه هاي مرتبـط با بهداشت و سلامت




## ارتباط روانشناسي سلامت با ساير حوزه هاي مرتبط با سلامت

## الگوي هاي تغيير رفتار :

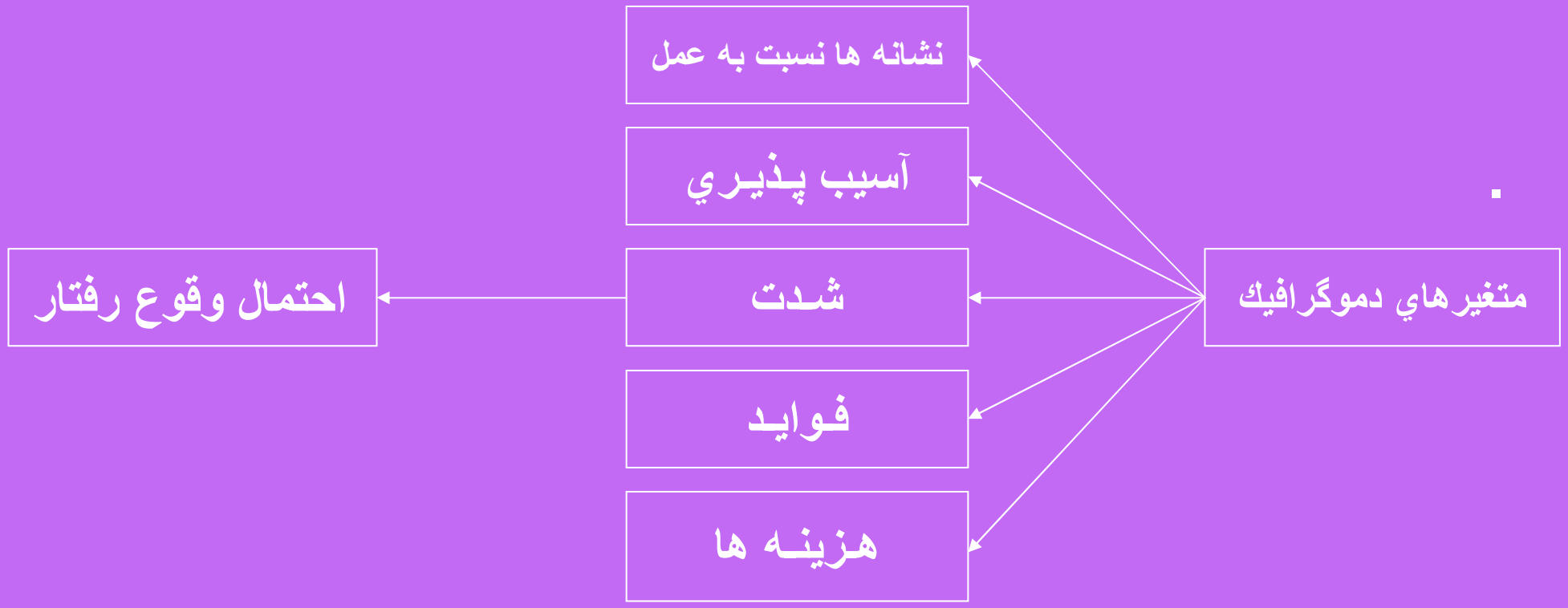
- الگوها : توصيف چيزي كه در عمل مي تواند باشد، نه اينكه در حقيقت بايد باشد.

بهترين حدسهايي هستند در مورد اينكه چه عواملي، به تنهايي يا در تركيب با عوامل ديگر، تغيير رفتار را پيش بيني مي كنند .

- الگوهاي تغيير رفتار در روانشناسي سلامت اغلب شناختي- اجتماعي اند.
- معروفترين و قديمي ترين الگوي شناختي

الگوي اعتقاد به سلامت ( روزن استوك1966 )

الگوي اعتقاد به سلامت : ابتدا توسط روزن استوك(1966) و سپس توسط بكر وهمكاران طي سالهاي دهه هاي 1970 و1980 به منظور پيش بيني رفتارهاي سالم و پيشگيري كننده و پاسخ به معالجات در بيماراني كه واقعا و به طور مزمن بيمار بودند، ارائه شد .



✵ اين الگو احتمال تمايل فرد به رفتار ناسالم ( مانند كشيدن سيگار ) را وابسته بـه عوامل زيـر مي داند :

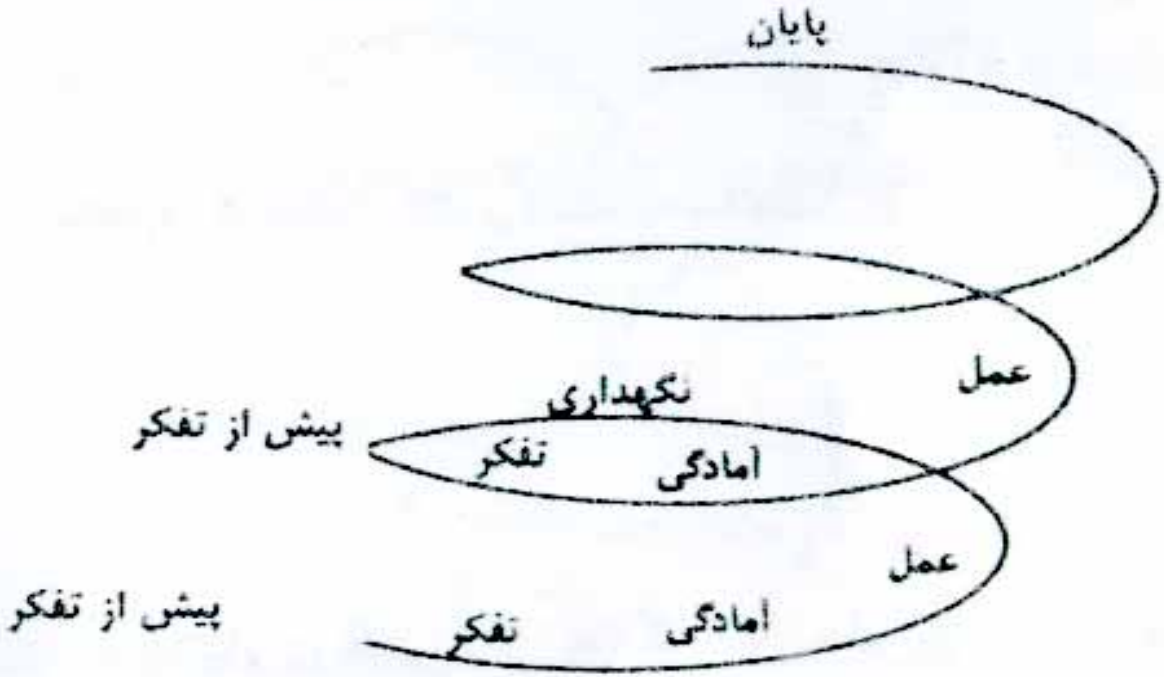
- نشانـه هاي درونـي ادراك شده ( مانند تـنگي نفس ) و يا نشانـه هاي خـارجي ( ماننـد بـروشورهايي در مورد استعمال سيگـار )
- آسيب پذيـري ادراك شـده ( مـاننـد در صورتـي كه سيگـار بكشم ، احتمال ابتلاي به سرطان ريـه بسيار زيـاد خواهد بود )
- شدت ادراك شده ( سرطان ريـه ، بيمـاري خطرناكي است )

- فواید ادراك شده ( داشتن پول بيشتر براي مصارف ديگر در صورت ترك سيگـار )
- هزينـه هاي ادراك شده ( تـرك سيگار- تحريك پذيـري )

⇦ در اين سنجشها ادراك نقش مهمي ايفا مي كند ، بنابراين ما اجازه نداريم در اين سنجشها عيني عمل كنيم .

## ارزيابي الگوي اعتقاد به سلامت :

- موفقيت در پيش بيني برخي از رفتارها مثل غربالگري سرطان در زنان و ارتباط قوي رفتار سالم با آسيب پذيري پايين ( مانند ورزش كردن وكاهش خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي )
- ناديده گرفتن عوامل محيطي و اجتماعي مؤثر برسلامت
- طبق اين الگو، انسانها بعد از وقوع رويداد، منطقي عمل مي كنند ، به جاي اينكه عوامل منطقي ، تغييري در رفتار ايجاد كند.
- كشف عوامل پيش بيني كننده قويتري براي تغيير رفتار در الگوي جديد ، مثل پيامد انتظار و خود كارآمدي
- ارائه الگوي كاري مفيدي كه مبناي الگوهاي پيشرفته تر و تحقيقات با ارزش تري در مورد تغيير رفتار شده است .




**شکل ۱-۵: الگوی مراحل تغییر**

منبع: پروچاسکا و همکاران ۱۹۹۲

## مراحل تغيير رفتار در الگوي مراحل تغيير رفتار :

مرحله1- پيش از تفكر( قصد تغيير نداشتن )

مرحله2- تفكر( در نظر گرفتن يك تغيير )

مرحله3- آمادگي ( به وجود آوردن تغييرات كوچك )

مرحله4- عمل ( به طور فعال دررفتارجديد درگيرشدن )

مرحله5- نگهداري ( نگهداري تغيير در طول زمان )

## ارزيابي الگوي مراحل تغيير :

- كاربرد موفقيت آميز در رفتارهاي وابسته به سلامت ( مانند ترك سيگار، ورزش و رفتار غربالگري سرطان ).
- برتري نسبت به الگوي اعتقاد به سلامت بدليل تشخيص دخالت « اهميت گذر زمان » در تغيير رفتار و اجازه به افراد براي تمركز بر پاداش و هزينه ها درهر مرحله از تغيير.
- پيوند دادن اهداف سلامت رفتار با مراحل و فرايندهاي درازمدت براي تحقق تغيير رفتار مردم .
- مشكل بودن تشخيص مرحله اي كه فرد در آن بسر مي برد (مثل آماده شدن10 تا 15 درصد معتادان به سيگار براي عمل و اكثر آنها در مراحل پيش ازتفكر و تفكر بودند).

(پروچاسكا و همكاران 1992)

## مقايسه الگوها :

اتفاق نظر در پيش بيني كننده هاي مهم رفتارهاي سالم پيشگيرانه :

- خطر ادراك شده
- شدت درك شده بيمار
- سودمندي درك شده از پيشگيري
- هنجارهاي اجتماعي
- خودكارآمدي
- تحليل سود – هزينه

( پيتزوفيليپس ، 1998 )

تك بـررسي تغييـر رفتـار :

سرطان بيضه = شايعترين سرطان و يكي از علل مهم مرگ در مردان 15 تا 35 سال بـه شمار مي رود كه در تضـاد مستقيـم بـا سرطـان سينه در زنـان است ، به دليل هشيـاري كـامل زنـان و آگـاهي از شيوه هاي مراقبـت .

خـودآزمـايـي بيضـه ، كـاملا شبيـه خـودآزمـايـي پسـتـان .

شـامل آشـنـايـي بـا سـطـح بيـرونـي ، بـافـت و يـكـنـواخـتـي بيضـه هـا ، مـعـايـنـه در طـي حـمـام يـا دوش آبـگـرم ، و مـعـايـنـه هـر دو بيضـه بـا حـركـت چـرخـشـي انـگـشـت شسـت واشـاره ، تـا مشخص شود كه تمام سطح فـاقد غده است.

( هانـگلدرم و هانـگلدرم 1982 )

## فصل دوم :

همه گيري شناسي اجتماعي و سياست سلامت

- تعريف همه گيري شناسي
- مرگ ومير و آمار ابتلا به بيماري
- كيفيت زندگي
- سياست سلامت

## همه گيرشناسي اجتماعي و سياست سلامت :

- علاقه روانشناسان سلامت به مطالعه سلامت فردي و اجتماعي

- همه گيرشناسي : مطالعه فراواني ، شيوع و علل بيماري هاي عفوني و غيرعفوني در جمعيت عمومي بر اساس بررسي محيط فيزيكي و اجتماعي( تيلور1995، ص9 ) و تمركز روي جمعيت ها نه افراد خاص .

- بـررسي ابتلا به نوع بيماري (مثل سرطان ) و تلاش بـراي يافتن دليل شيوع برخي از بيماريها (مثل سرطانـها ) در مناطق جغرافيايي خاص .

- نخستين بررسي همه گيرشناسي« جـان اسنـو » پزشك انـگليسي 1849 وي مشاهده كرد كه بيماري همه گير « وبا » در لندن ، به طور عمده در مناطقي رخ مي دهد كه از پمپ آب خيابـان بـراود استفاده مـي كنند .

## بزرگترين چالش اپيدميولوژيستهاي كنوني :

ارتباط بين عوامل ژنتيكي ، زيست شناسي ، روانشناختي ، اجتماعي و نقش آنها در بروز و درمان بيماريهاي مزمني مانند بيماري قلبي و سرطان.

## مرگ ومير و ميزان ابتلا به بيماري :

1- ميزان ابتلا ← تعداد موارد يك بيماري در زمان مشخص
2- ميزان شيوع ← تعداد كل موارد موجود
3- ميزان بروز ← تعداد موارد جديد

◈ اندازه گيري ميزان ابتلا به بيماري و مرگ ومير، از ابزارهاي ضروري براي طراحي، اجرا و ارزيابي طيفي از سياست ها و به كارگيري مراقبتهاي بهداشتي است .

## علل عمده ناتواني و مرگ :

1- بيماريهاي مزمن ( يعني بيماريهاي درازمدتي كه درمان پذير نيستند و فقط كنترل ميشوند ) مانند : بيماريهاي قلبي، سرطان ، ديابت كه شرايط پيچيده چند عاملي دارند .

2- دخالت عوامل روانشناختي و اجتماعي درتمام مراحل پيشرفت اين اختلالات .

## يافته هاي پژوهشي :

1- اهميت علل محيطي و اجتماعي به اندازه سبك زندگي فردي در ارتقاي سلامت و پيشگيري از مرگ زودرس( ر.ك. فصل7 )
2- ژاپن داراي كمترين مرگ ومير نوزادان و بيشترين سطح اميد به زندگي در جهان ،با وجود اين كه توكيو بزرگترين ، آلوده ترين و متراكم ترين شهرهاي دنياست(هارت به نقل از هالند وهمكاران ، 1991 )

دليل :

- ✓ مهندسي اجتماعي ( ايجاد محيطي انساني توسط انسان )
- ✓ رد اين افسانه كه زندگي در دامن طبيعت كامل تر و سالمتر از زندگي در جامعه صنعتي است ( انسان صنعتي دو برابر از اجداد عصر سنگي اش مقاومتر است ).

- ✓ بالا بودن آمار ابتلا به بيماري و مرگ ومير در كشورهايي كه با شرايط ضعيف اجتماعي و اقتصادي اداره مي شوند .

مثال :

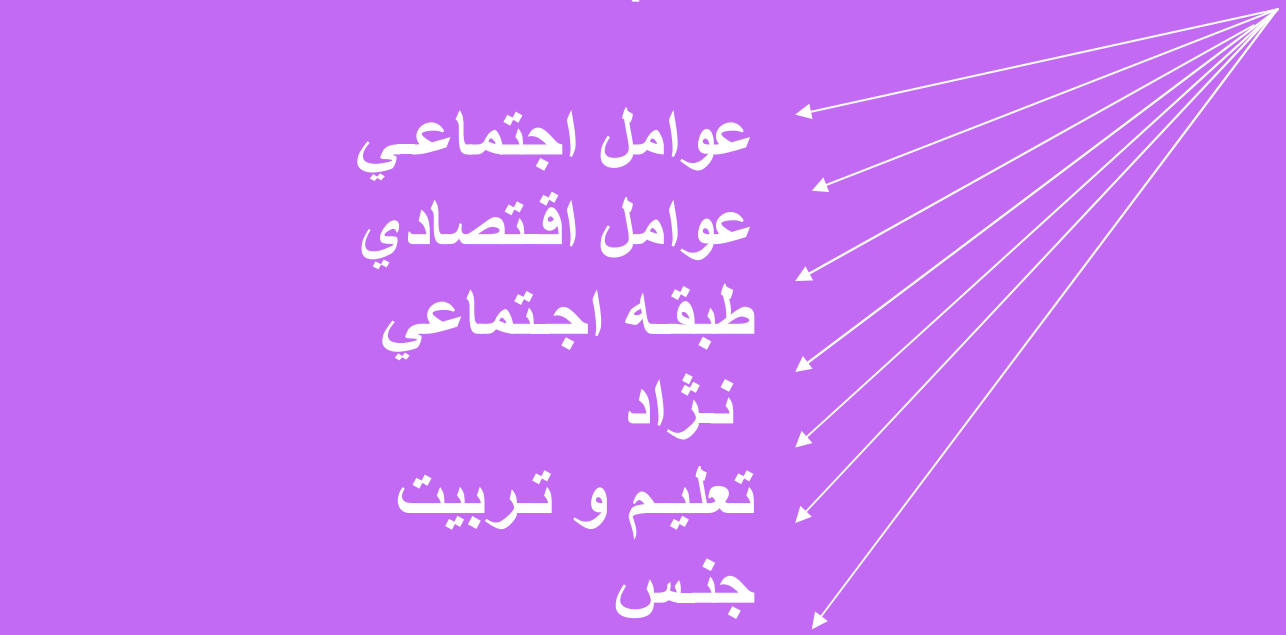
نرخ خودكشي در مجارستان

- دو برابر فرانسه
- سه ونيم برابر آمريكا
- پنج برابر انگلستان

- ✓ بالا بودن مرگ ومير ناشي از تصادفات و قتل (جنايت) در مجارستان ، به علت وجود وحدت اجتماعي ضعيف و احساس ضعيفي از تعلق به اين كشور.

## عوامل مؤثر بر مرگ ومير و ميزان ابتلاي به بيماري

(هارت ، به نقل از هالند و همكاران 1991 ) :



## كيفيت زندگي :

- ✓ ادراك فردي از موقعيت زندگي خود در زمينه فرهنگ و نظام هاي ارزشي كه درآن زندگي مي كند و در رابطه با اهداف ، انتظارات ، معيارها و دلمشغولي ها ( WHOQOL ) .
- ✓ قضاوت ادراك شده فردي در مورد ميزان رضايت از زندگي كه ممكن است شباهت كمي به وضعيت سلامت جسمي واقعي آنها داشته باشد .
- ✓ سال هاي زندگي سازش يافته از كيفيت ( QALYS ) به عنوان مبناي قضاوت در تخمين اختلالات .

ابزار كيفيت زندگي بين فرهنگي ( WHOQOL ) كاربرد براي :

- ❖ بيمارانـي كه بيماري هاي مزمـن دارند ( ماننـد درد مفاصل )
- ❖ افرادي كه در وضعيت استرس شديد به سرمي برند ( مانند مهاجران و پناهندگان )
- ❖ مراقبان غيـر رسمي افـراد سالمند و نـاتوان .

الگوي سازه هاي كيفيت زندگي وابسته به سلامت شامل : سازه اي از ارزيابي هاي مثبت و مقياس رضايت از بيماري ، مانند :

1- بيماري باعث شده كه ارزش زندگي ام را بيش از آنچه قبلا مي دانستم ، درك كنم .
2- با وجود مشكلات ، از زندگي ام لذت مي برم .
3- بيماري ام ، ارزش دوستي را به من نشان داده است .
4- وقتي كه احساس خوبي دارم ، واقعا احساس خوشحالي مي كنم .
5- بستگانم ، واقعا به مشكلاتم اهميت مي دهند .
6- بيماري ام به من كمك كرده كه خودم را بشناسم .

( هيلند و كنيون 1992 )

## ارزيابي كيفيت زندگي :

- ☑ كيفيت زنـدگي = سازه بي نـهايت ارزشمندي براي سنجش اينكه فرد چه احساسي در مورد وضعيـت و شرايـط سلامت خود دارد .
- ☑ داراي ماهيت ذهـني است لذا اعتبار و روايي فرهنگي آن ، چالش انـگيز است .
- ☑ مسايل اخلاقي در كيفيت زندگي (مثل ارزش قايل شدن براي زندگي چه معنـي دارد ؟ )
- ☑ ( پژوهش هيلند و كنيون1992 ) در مورد كيفيت زندگي بيـماري ممكن است تغييـرات مـثبتي را در زنـدگي بيمار به همراه داشته باشد و باعث شود كه آنـها بيشتر در مورد خـود ياد بـگيرند و از بستگان و دوستانشان قـدرداني كننـد .

## سیاست سلامت :

- درك اپيدميولوژي بدون درنظر گرفتن سياست سلامت = ناقص
- مراقبت از سلامت - يك ارزش فوق العاده و منبع ارزشمند مثال :

« قانون خدمات سلامت ملي » حكومت كارگري انگلستان در سال1948 ، زمينه تاسيس «خدمات سلامت ملي» را براي دسترسي تمام افرادي كه به آن نياز دارند و به صورت رايگان ، براي وزير بهداشت فراهم كرد.

## بزرگترين چالش بهداشتي قرن جديد :

☑ دسترسي به خدمات مراقبتهاي بهداشتي و نياز به كاهش نابرابري ها در بهداشت ( مانند روستايي ، منطقه اي و... )

روزنامه مشاوره حکومت ، « ملت سالمترها : پيماني براي سلامت » (1998)
درصدد است تا « راه ميانـه اي » بين تعصب هاي قديمي « سرزنش قرباني
فردي » از يك سو و « مـهنـدسي اجتماعـي دولـت دايـه » از سوي ديگر
بيابد . اين راه ميانبـر با هدف ايـجاد و حـفظ همكـاري قـوي بيـن افراد ،
خانواده ها ، نمايندگان محلي و جوامع ، بنا مي شود .

## هزينه مراقبتهاي بهداشتي :

انـگلستـان در سطح جهان داراي پايين ترين سطح هزينه كلي مراقبت از بـهداشتي را به نسبت درصد « تـوليد نـاخالـص مـلـي » به نسبت تمام سازمان هاي همكاري هاي اقتـصادي و تـوسعه اي كـشورها است ؛ بـا صرف به طور متوسط كمتر از 7 درصد از توليد ناخالص ملي خود براي هزينه كلي مراقبتهاي بهداشتي ، طي سالهاي 1990 تا 1997 .

- آمـريكا دو برابر انـگلستان يعني بـه طور متوسط 14 درصـد بـراي كل مـراقـبتهاي بـهداشتي در طـي همين دوره هزينـه كـرده است . لذا سياست مراقبتهاي بهداشتي ارتباط نزديكي با تصميمات بـودجه دارد كـه در مـورد زمينـه هاي اجتماعـي ، سيـاسي و اقتـصادي اتـخاذ واجـرا مي شونـد .

# فصل سوم :

## نشـانه هاي بيمـاري و درد

- نشانه ها : اتخاذ رفتار نقش بيمار
- مقدمه اي بر درد
- تعريف درد
- تاريخچه درد
- ويژگي هاي درد
- نظريه هاي درد

## نشانه هاي بيماري و درد : اتخاذ رفتار نقش بيماري

برانون و فيست :

☑ پزشك ـــــعلاوه بر بستري كردن ، دروازه بان مراقبتهاي بهداشتي است.

☑ تعيين و تائيد بيماري با تشخيص پزشكان

( برانون و فيست ، 1997 ، ص166 )

## رفتار بيماري در برابر رفتار نقش بيماري :

☑ رفتار بيماري ← بروز قبل از تشخيص

☑ رفتار نقش بيماري ← بروز پس از تشخيص كه معمولا توسط پزشك انجام مي گيرد .

☑ تشخيص عامل تمايز رفتار بيماري از رفتار نقش بيماري

( كسل و كوب ، 1966 )

علل مؤثر در زمان ، مكان و نحوه كمك خواهي مردم در هر دو بيماري :

1- عوامل اجتماعي و جمعيت شناختي

2- ويژگيهاي نشانه هاي بيمار

## عوامل اجتماعي و جمعيت شناختي

✓ جنس :

- مراجعه زنان به طور متوسط به پزشك عمومي دو برابر مردان .
- بيشترين خطر تهديد كننده مردان ـــــــ مشكلات مربوط به مشروبات الكلي و ناامني شغلي .
- بيشترين خطر تهديد كننده زنان ـــــــ بي تحركي جسمي ، بيكاري و استرس .
- مردان به دليل انتظار داشتن ديدگاه اجتماعي قوي ، از پذيرش بيماري و اقدام براي مراقبت هاي پزشكي سر باز مي زنند .

وضعيت اجتماعي- اقتصادي :

* طبقه اجتماعي و اقتصادي بالاتر ـــــ داراي پذيرش بيشتر در مورد رفتارهاي پيشگيرانه سلامت
* نقش عوامل فرهنگي و اجتماعي در پاسخدهي به نشانه هاي بيماري .

مثال: صبورترين افراد در انكار درد ـــــ آمريكاييهاي ايرلندي

* آمريكاييهاي يهودي ، بيشتر درصدد دريافت كمك هاي تخصصي اند ، نقش بيماري را قبول مي كنند و درگير رفتارهاي پيشگيرانه مي شوند ( برعكس آمريكاييهاي مكزيكي )

( مكانيك 1978 )

* جوانان و ميانسالان ←——— بيشترين اكراه براي دريافت مراقبت از سلامت
* نـوجـوانـان پسـر ←——— بيشترين نارضايتي و ناخشنودي

( گارلند و زيگلر ، 1994 )

* سـالمنـدان همانند ميانسالان تحت تأثير اين جمله كه « بـايد مربـوط به سنـم باشد » قرار نـمي گيرنـد و حتي در بيماريهاي مشابه زودتـر درصدد دريافت توصيه هاي پـزشكي برمي آينـد .

( لونتال و دايفن باخ ، 1991 )

☑ ويژگي هاي نشانه هاي بيماري

- قابل مشاهده بودن
- شدت
- تداخل با زندگي روزانه
- فراواني و تداوم

( مكانيك ، 1978، نقل از برانون و فيست ، 1997 )

1- قابل مشاهده بودن نشانه ها :

- سهولت آشكار شدن به فرد و ديگران
- افراد براي نشانه هاي قابل مشاهده احتمالا درصدد دريافت كمك برمي آيند تا علايم ناآشكار

2- شدت نشانه ها :

- شدت ادراك شده نشانه ها با درخواست كمك ارتباط دارد ( يعني هر چه نشانه هاي ادراك شده شديدتر باشد ، احتمال بيشتري براي درخواست كمك وجود دارد . ( مكانيك ، 1978 )
- علايمي كه جدي تلقي مي شوند ←ايجاد دلمشغولي بيشتر + تعبير به بيماري (ساچمن ، 1965 )
- شدت ادراك شده از علايم ، مهمتر از نشانه هاي قابل مشاهده در : تصميم براي دريافت مراقبت از سلامت (كامرون و همكاران ،1993) توجيه : توسعه شيوه هايي براي درك واقع بينانه و منطبق بر نظر متخصصان پزشكي توسط بيمار از نشانه هاي خودش .

3 - تداخل نشانه ها با زندگي روزانه :

- هرچه شخص ناتوان تر ——احتمال اين كه درصدد مراقبتهاي پزشكي برآيد بيشتر است .
- نظريه ساچمن (1965) ، مؤيد نظريه مكانيك (1978) : دخالت نشانه هايي در زندگي شخص = احتمال تعبير ضرورت و تأئيد كمك پزشكي بيشتر.

4 - فراواني و تداوم نشانه ها :

- درد مداوم ، نسبت به يك درد متناوب ، احتمال بيشتري دارد كه به معاينه پزشكي بيانجامد .

## ساختار اجتماعي سلامت و بيماري

- ☑ خوش بيني غيرواقعي ( وين اشتاين ، 1984 ) ، ديدگاه شخصي فرد و آگاهي او از بيماري خود ممكن است به تحريف افكارش در مورد علل ، آثار و درمان منجر شود .
- ☑ ناآگاهي و اطلاع ناكافي بيشتر مردم در مورد : چگونگي كار و بيمار شدن بدن و....

توجيه : مطالعه متن عالي توضيح سلامت و بيماري

( اشتاين توين و راجرز ، 1991 )

## مقدمه اي بر درد :

- علاقـه روانشناسان به مطالعه درد بـدليل اينـكه درد علاوه بـر جنبه جسمي ، جنبه روانشناختي نيز دارد .

☑ درد حتـي وحشتناك تر از مرگ براي انسان است. ( آلبرت شوايتزر )

☑ درد شايـع تريـن علامت پزشكـي است كه بـه هنـگام درخـواست كمك از پزشكان مطرح مي شود.

## تعريف درد :

☑ احساس يا تجـربه هيجاني ناخوشايندي كه با آسيب واقعي يا بـالقوه بافت همراه است يا برحسب چنين آسيبي توصيف مي شود .
( مرسكي و همكاران ، 1979 )

☑ درد هميشه ذهني و ناخوشايند است. ( تجربه هيجاني )

☑ تجربيات شبيه درد ولـي خوشايند و نيز تجـربيات ناخوشايندي كـه كيفيتهاي حسي ندارند ، درد نيستند. ( اسكوينگتـون ، 1995 )

## تاريخچه درد :

☑ قرون وسطي

✵ افـراد نظامـي با بي اعتنايي به درد مي نـگريستند و آن را حالت زنانه بي ارزشي تلقي مي كردند.

✵ روحانيون درد را علامت تأديب الـهي مي ديدند .

( دوبي ، 1993 نقل ازاسكوينـگتون 1995 )

✵شكل گيري اين نظريه كه : درد چيزي است كه بايد تسكين داده شود ( در قرن13 ) به دنبال موضوع محوري رنـج حضـرت مسـيح بـراي آنـهايي كه به كليسا مي رفتند .

☑ امروزه

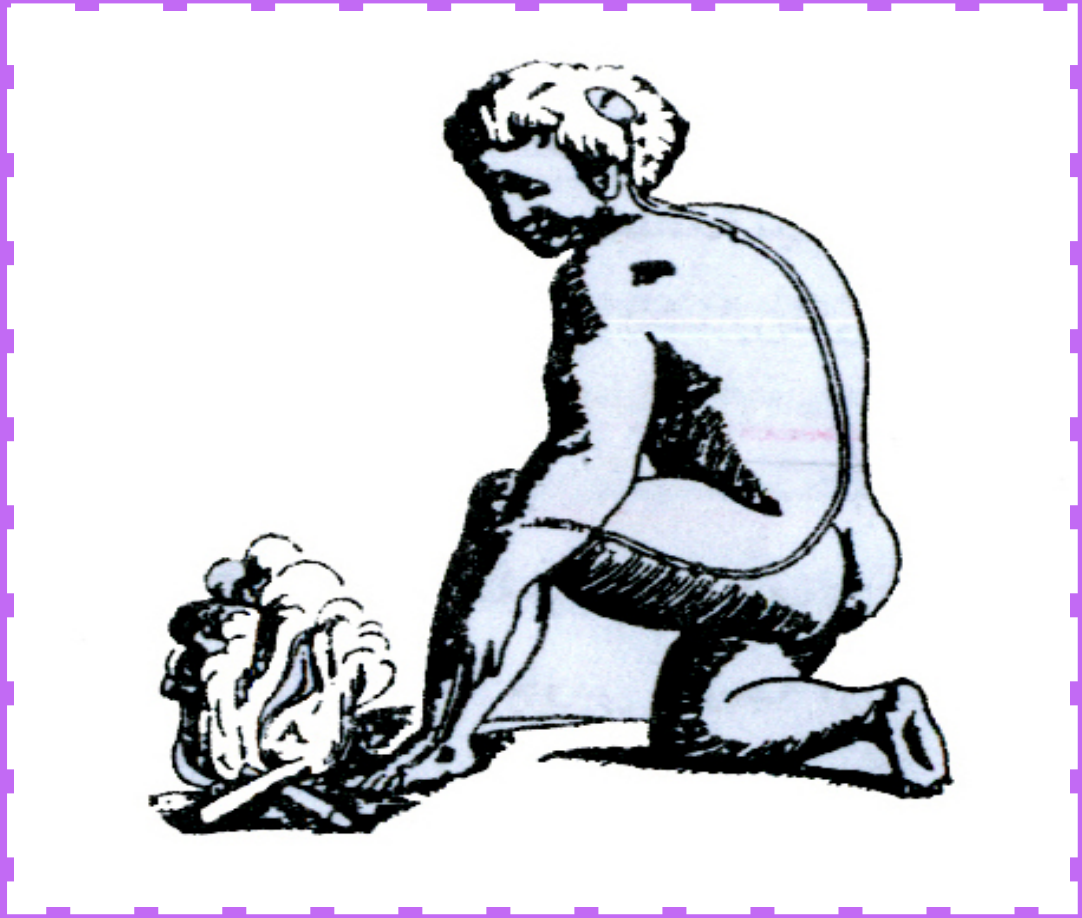
✵ درد عارضه بيولوژيك در نظر گرفته نـمي شود ، بلكه حالتي است سزاوار مراقبت و تـوجه .

✵ تفاوت هاي فرهنگي در آستانه ادراك درد

عوامل فرهنگي موجب عوامل اجتماعي و تحولي شده و اين عوامل بر تجـربه و گزارش درد تأثير مي گذارنـد .

# الگوي اوليه درد

قديمي ترين تلاش براي توصيف محل درد ، در رساله دكارت ( 1664 )
درباره انسان



مسير درد از مركز پا تا مغز امتداد يافته است .

## ويژگيهاي درد :

**1- آسيب بـدون درد**

* نداشتن حس درد ، فقدان حس درد موضعي
* توانايي تجربه درد براي بقاي ما مفيد است، زيرا بدن را نسبت به خطرهاي احتمالي آگـاه مي سازد .

## 2- درد تـأخيري پس از آسيـب

- متداولترين شكل فقدان حس درد ——تجـربه درد پـس از گذشت مـدتي از آسيـب آن .

## 3- درد بـدون آسيب

– درد عصبـي ـــــ درد شديد ناگهاني كه در مسير اعصاب امتداد مي يابد و ممكن است پس از اين كه بيمـاري ضايـعه عصبي ( مثل تب خال ) تمام شد ، رخ دهد .

- سوزش عصبي ـــــ درد سوزنده اي است كه اغلب به دنبال زخم شديد به وجود مي آيد .

- سر درد

- درد اندام خيالي ( بن يارد ، 1996 ) - بيش از $\frac{2}{3}$ از افرادي كـه مبتـلا بـه قطـع عضـو هسـتند از درد در خيـال خـود رنـج مـي برند .

**4- درد اندام خيالي**

* از دست دادن يك عضو/ تولد بدون يك عضو ← ممكن است تمام حس هاي آن عضو را احساس نموده و به ميزان زيادي درد بسيار واقعي از اندام خيالي شان را تجربه كنند.
* بيماران با عضو خيالي ، تجربيات مشترك گزارش مي كنند( ملزاك1992 نقل از بن يارد 1996 )

☑ پايه هاي بيولوژيكي درد اندام خيالي

* سخت شدن انتهاي عصب ← انتقال به گره ها (نوروما) ← توليد تكانه هاي عصبي ← تعبير به تكانه هاي عضو ( توسط مغز )

مغز : شبكه اي از نرون ها يا بافت نروني ← پاسخدهي به اطلاعات حسي و توليد الگوي مشخصي از پيامهاي عصبي دال بر اين كه بدن « يكپارچه » است . ( پديده نوروسيگنيچر )

## 5 - درد بدون تناسب

* عدم تناسب درد گزارش شده با آسيب وارده .

مثال : انواع مختلف سرطان به رغم ايجاد آسيب فراوان در بافتهاي بدن ، تا هنگام پيشرفت بيماري درد بسيار كمي ايجاد مي نمايند .

* درد تجربه اي به شدت شخصي و ذهني است و ممكن است به عوامل جسمي يا آسيب شناختي مربوط باشد .

- نظريه هاي درد
  - نظريه ويژه درد
  - نظريه هاي الگوي درد
  - نظريه مهار دروازه (دكارت ،1664)

- سال 1842 ← روش شناسي پيشرفته ← درك اين كه درد توسط اعصاب درد به مغز منتقل مي شود .

## نظريه ويژه درد :

- بخش ويژه اي از اعصاب ( گيرنده هاي درد ) پيامها را از گيرنده هاي درد در پوست به مركز درد در مغز انتقال مي دهند .
- تارهاي عصبي فقط درد را ايجاد مي كنند ، نه حس هاي ديگر را .
- بين ساختار عصبي و تجربه روانشناختي ما از درد ارتباط يك به يك است .

نرونهاي مؤثر در تشخيص درد :

تارهاي عصبي آ - بتا ——— با پوشش ميليني قوي ( عملكرد سريع )

تارهاي عصبي آ- دلتا ——— با پوشش ميليني خيلي ضعيف ( آهسته تر )

تارهاي عصبي سي ——— بدون ميلين

* با الگوي متفاوت پاسخ به تحريك ناشي از تجربه درد

## نظريه هاي الگوي درد

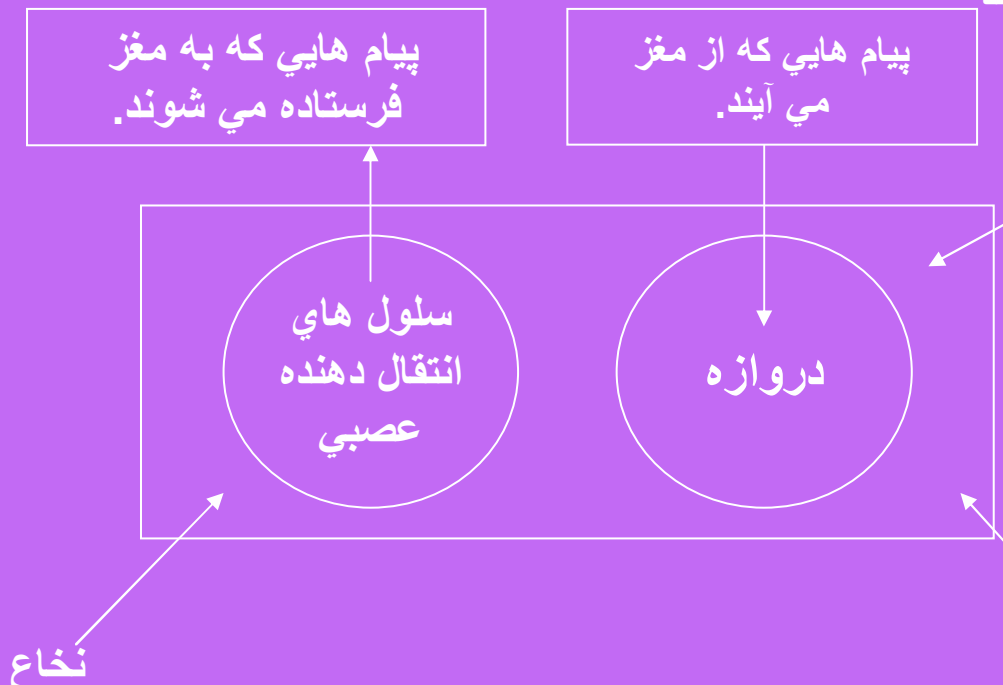
- نظام جداگانه اي براي ادراك درد وجود ندارد ، بلكه اعصاب در ساير حس ها سهيم اند ، تارهاي عصبي درد از اندام ها به مغز و از آنجا به اندام ها مي روند .

☑ نظريه مهار دروازه :

اولين بار توسط ملزاك و وال در سال 1965 طي مقاله مشهور « مكانيزم درد : نظريه اي نوين » در « مجله سانيس » طرح شد .

- رويكرد پزشكي نظريه هاي قبلي را با جديدترين الگوي زيستي ، رواني ، اجتماعي ، سلامت تلفيق كرد .
- عدم توجه صرف به عوامل پزشكي بلكه در نظر گرفتن بين عوامل زيست شناختي ، روانشناختي و اجتماعي در رابطه با درد .

عصب هاي درد، به طور فعال
دروازه را باز مي كنند و به پيام هاي درد
اجازه ورود به سلولهاي انتقال دهنده را مي دهند




سايرِ اعصاب حسي به طور فعال
دروازه را مي بندند و از رفتن پيام هاي
درد به سلول هاي انتقال دهنده جلوگيري مي كنند

نظريه مهار دروازه
منبع : كرتيس(1999)به نقل از بن يارد(1996)

* اعتقاد به وجود يك دروازه يا به عبارت دقيق تر يك مكانيزم دروازه اي در نظام عصبي كه در پاسخ به عوامل مختلف باز و بسته مي شود .
* باز شدن دروازه = اجازه ورود و انتقال پيامهاي درد به مغز
* بسته شدن دروازه = جلوگيري از انتقال پيامها به مغز ( كاهش درد پاي آسيب ديده با مالش )
* درد مسير دوطرفه اي از اطلاعات به سمت مغز و از جانب مغز
* مغز ← پردازش اين داده ها + تأثير مستقيم بر مكانيزم دروازه اي .

## جدول 3-1 ؛ عوامل مؤثر در مكانيزم دروازه اي

| | شرايطي كه موجب باز شدن دروازه مي شوند | شرايطي كه موجب بسته شدن دروازه مي شوند |
|---|---|---|
| جسمي | گستردگي آسيب/آسيب بافتي | ماساژ دادن |
| هيجاني | اضطراب | تنش زدايي |
| رواني | تمركز روي درد | منحرف كردن حواس از درد |

## ارزيابي نظريه مهار دروازه :

- تأييد تجربي زياد تحقيقات
- بهترين راه براي توضيح بسياري از ويژگي هاي معماگونه درد
- تجربه درد محصول تجمع حس هاي مختلف در نخاع ( پديده تجمع فضايي )
- موجه ترين و هيجان انگيزترين الگوي درد ، هم براي درك بيشتر از مكانيزم هاي مربوط و هم به لحاظ كاربرد آن در طراحي درمان مؤثر

فصل چهارم :

درد : ارزيابي ، كنترل و درما ن

- **اندازه گيري درد**
- **درمان پزشكي درد**
- **درمان هاي روانشناختي درد**
- **رويكردهاي چند وجهي**
- **درمان هاي چند رشته اي : كلينيك درد**

انـدازه گيري درد ـــــبه علت مـاهيت ذهني تـجربه درد مشكل ولـي بسيار مهم

اندازه گيري فيزيولوژيكي درد ( سيرجالا و چاپمن1984 ) :

تنش عضلاني
شـاخص هاي خودمختار ( خود تنظيم )
پتانسيل هاي فراخوانده

## 1- تنش عضلاني :

* براي اندازه گيري سطح تنش عضلاني در بيماراني كه به طور خفيف از درد كمر رنج مي برند با استفاده از برق نگاري ماهيچه اي ( EMG ) كه سنجش معتبر و مطمئني از درد نيست .

## 2- شاخصهاي خود مختار ( خود تنظيم ) :

- اندازه گيري فرايندهاي غيرارادي نظير نفس نفس زدن ، جريان خون در سرخرگگيجگاهي ، ضربان قلب ، حرارت سطح دست ، اندازه ضربان انگشت و سطح مقاومت پوست

## 3- پتانسيل هاي فـراخوانـده

- علايم الكتريكي ايـجاد شده توسط مغز در پـاسخ بـه محرك حسي
- در ماهيت شبيه برق نگاري مغز ( EEG ) هستند و تمام فعاليتهاي الكتريكي مغز را اندازه گيري مي كنند .
- افـزايش حتي در هنگام ثابت ماندن گزارشهاي ذهني درد ، لذا اين شيوه اندازه گيري فيزيولوژيكي اعتبار و روايي ندارد .

## ارزيابي رفتاري

بهترين روش اندازه گيري درد ←— مشاهده و ثبت رفتار بيمار دردمند

شيوه هاي خودگزارش دهي :

- مقياسهاي درجه بندي
  - مقياس عددي
  - مقياس تطابق بينايي
- پرسشنامه هاي درد
- آزمون هاي شخصيت

☑ مقياس هاي عددي وتطابق بينايي ، مقياس هاي درجه بندي معتبر قابل قبولي هستند.

☑ گيـج كننده بـودن آنـها براي بيمـاران مسن و بي توجهي به جنبه هاي مختلف درد ( انتقاد )

## 2- پرسشنامه هاي درد

ملزاك به شدت از مقياسهاي درجه بندي انتقاد كرد و معتقد است اندازه گيري درد با روش درجه بندي شبيه مشخص كردن دنياي ديداري ما فقط بر حسب نور ، بدودن در نظر گرفتن ططرح ، رنگ يا بافت آن است به همين خاطر پرسشنامه درد مك گيل را در سال 1975 توسعه داد .

## پرسشنامه درد مك گيل :

امكان اندازه گيري ذهني از درد و طبقه بندي درد از سه بعد :

- كيفيت هاي حسي ( خواص زماني ، فضايي ، فشاري و حرارتي درد ) ← شبيه مشخص كردن ابعاد جسمي
- كيفيت هاي عاطفي ( ترس ، تنش و كيفيت هاي خود مختار درد ) ← شبيه مشخص كردن احساسات همراه با درد
- كيفيت هاي ارزيابي ( شدت كلي تجربه ذهني درد ) ← شبيه مشخص كردن معناي تجربه درد

## بخش هاي پرسشنامه درد مك گيل

1- ترسيم شكل انسان از روبه رو و پشت كه بيمار
در اين شكل ها، محل احساس درد را علامت مي زند .
2- متشكل از بيست سري كلمه
توصيف كننده درد كه بيماران بايد دور يك كلمه از هر سري كه درد آنها را دقيق تر توصيف مي كند، دايره بكشند.
3- اين سؤال كه درد بيمار در طول زمان چگونه تغييركرده است
تا اندازه اي ازميزان تداوم درد در اختيار بگذارد .
4- به كارگيري مقياس پنج نقطه اي درجه بندي شده از درد خفيف تا شديد كه شدت درد را اندازه گيري مي كند.

## ارزيابي پرسشنامه درد مك گيل :

- ✓ از روشهاي اندازه گيري چند بعدي درد است .
- ✓ روايي متوسطي را در سنجش درد سرطان ، سردردها و چندين سندرم درد ديگر به نمايش گذاشته است.
- ✓ به علت كلمات مشكل و نداشتن شكل نمره گذاري استاندارد مورد انتقاد

# درمان هاي پزشكي براي درد

- ماهيت درد ذهني است و توسط عوامل روانشناختي وساطت مي شود، پس درمان بايد چنين رويكرد شخص مدار و التقاطي را منعكس كند .
- بنا به ماهيت و محل تجربه درد، متفاوت و شامل:
  - داروها : تسكين ناآگاهانه درد
  - تحريك الكتريكي اعصاب ماوراء پوستي (TENS)
  - طب سوزني
  - جراحي

## 1- داروها

الف - نوع آسپرين : تركيب فعالي به نام ساليسين ـــــ خاصيت ضد درد و پيشگيري از التهاب و تب ـــــ داروهاي غيراستروئيدي و ضد التهاب، اين داروها به ويژه براي درد همراه با آسيب مفيد است.

ب- نوع افيون

2- تحريك الكتريكي اعصاب ماوراء پوستي ( TENS ) از اوايل دهه 1970 بيماران التهاب مفاصل تسكين درد زايمان

- ✓ حصول تسكين درد نه تنها در مدت تحريك ، و تداوم آن حتي ساعتها پس از تحريك با كاربرد مؤثر در درمان دردهاي حاد و مزمن

ارزيابي TENS :

- ✓ در مقايسه با دارودرماني يا جراحي در تسكين درد مؤثر نبوده
- ✓ در تسكين درد زنان باردار در طول مرحله اول درد زايمان با « دارونما » اختلاف اثر معني داري ندارد .
- ✓ در تسكين جراحي ها پس از روش هاي درماني مؤثر است .

## 3- طب سوزني :

روش دردزدايي باستاني چين ، شامل فروكردن سوزن هايي به نقاط خاصي از پوست و سپس تحريك مداوم آنها .

اين تحريك به طور الكتريكي و يا چرخشي دستي سوزنها انجام مي شود ، فقط در حدود 10 درصد از بيماران در طول جراحي تا تسكين درد ، درد زدايي كافي را تجربه مي كنند . آثار دردزدايي فوري نيست.

## ارزيـابي طب سوزنـي :

- ✧ براي ايجاد اثر تسكيني وقت گير است اما با ايجاد تأثير درد زدايي براي چندين ساعت پس از توقف محرك ماندگار است.
- ✧ تـأثير بيشتـري در تسكيـن درد نسبت به دارونـما دارد ( ملزاك و و وال ، 1982 )
- ✧ نتايج قاطعي از مؤثر بودن آن وجود ندارد (چاپمن و گان ،1990 )

## 4- جراحي :

- آخرين روش در مداواي درد و تنها راهكار زماني كه ساير روشهاي درماني بي نتيجه مانده اند .
- به طور خاص براي تسكين نشانه هاي كمردرد خفيف استفاده شده .
- قابليت انجام براي كنترل درد ، در هر سطحي از نظام عصبي .

محلهاي ممكن براي جراحي، شامل اعصاب پيراموني نزديك به محل .

اعصاب پيراموني

تارهاي اعصاب حسي

تارهاي اعصاب حركتي

- اعصاب در بخش پيراموني دوباره ترميم مي شود ، برخلاف اعصاب در نظام عصبي مركزي .

☑ جراحي در غده ريشه خلفي ( درست خارج از نخاع ) فقط شامل فقدان شديد حسي مي شود ، نه فقدان حركتي .

☑ ساير محلها براي اقدامات جراحي شامل نخاع و مغز است .

☑ در مورد نخاع ، در ناحيه زير ضايعه ، معمولا فقدان كامل حس پديد مي آيد. بنابراين ، اين نوع جراحي معمولا فقط براي بيماران در شرايط نهايي اجرا مي شود تا براي مدت باقيمانده از عمر ، دردشان تسكين يابد .

## درمان هاي روانشناختي درد :

- خواب مصنوعي ، آموزش تنش زدايي ، پسخوراند زيستي ، تغيير رفتار، شناخت درماني( مانند خودكارآمدي ) و رويكرد چندوجهي .

## 1- خواب مصنوعي :

- حالت تغييريافته هشياري كه درآن جريان هشياري شخص تقسيم مي شود . ( هيلگارد ، 1979 )
- ابزار باليني مؤثر و فقط براي انواع خاصي از درد مثل : درد زايمان ، سردرد ، دردسرطان ، كمردرد خفيف ، درد ماهيچه صورت ، درد ناشي از كار در آزمايشگاه .
- فرايند القا ( قرار گرفتن در حالت خواب مصنوعي ) به فرد اجازه مي دهد به « تلقين » پاسخ دهد و فرايندهاي فيزيولوژيكي غيرقابل كنترل درحالت هوشياري طبيعي را كنترل كند .

- ☑ تلقين پذيري در غياب حالت « شبه خلسه » مؤثر است .
- ☑ متغير مهم نوع بيماراست نه نوع درد( برانون و فيست ، 1997 )

خواب مصنوعي بر عناصر ذهني گزارش دهنده درد عمل مي كند، نه بر مكانيزم هاي فيزيولوژيكي اساسي .

## ارزيابي خواب مصنوعي :

- دردزداي مؤثري براي تسكين درد سوختگي .
- موفقيت در وقفه تجربه درد
- براي گروه خاصي از افراد (حساس ) و انواع خاصي ازدردها موجب تسكين درد مي شود .

## 2- آموزش تنش زدايي :

- ☑ ساده نرين روش براي درمان درد
- ☑ به عنوان شكلي از مداوا در تنفس و آهنگ موزون در بين مصريان قديم ، عبريان و تبتي ها
- ☑ تنش زدايي تدريجي به جاكوبسون نسبت داده مي شود .
- ☑ طراحي آموزش تنش زدايي ، براي درمان گستره اي از بيماريها شامل فشارخون بالا ، سردردهاي تنشي ، دردهاي مزمن ، درد سوختگي ، تهوع و اضطراب .

## 3- تنش زدايي عضلاني تدريجي :

- جلسات آموزش تنش زدايي10 جلسه در طول 6 تا 8 هفته ، با آموزش آرامش عضلاني عميق به بيماران .

## 4- تنش زدايي مبتني بر مراقبه :

- توسط بنسون ارائه و از تمرين هاي مراقبه اي مذاهب مختلف استخراج شده است .
- بنسون ، تنش زدايي عضلاني را با محيط آرام ، وضعيت راحت ، يك صداي يكنواخت و يك بازخورد نافعال تركيب مي كند .

- شركت كنندگان با چشم هاي بسته و عضلات آرامش يافته مي نشينند ، سپس روي تنفس خود متمركز مي شوند و در سكوت ، يك صدا را با هر نفس به مدت 20 دقيقه تكرار مي كنند . اين حالت باعث جلوگيري از انحراف افكار مي شود و آرامش ماهيچه ها ادامه مي يابد .

## 5- مراقبه آگاهانه :

* راه ديگري از تنش زدايي مراقبه اي
* ريشه در بودائيسم
* در درمان افرادي كه از استرس ، اضطراب يا درد رنج مي برند به كار مي رود .
* ناديده نگرفتن افكار يا احساس هاي ناخوشايند از طريق تمركز بر تنفس يا يك صداي واحد بلكه در آغوش گرفتن اين افكار

## 6- تجسم هدايت شده :

* در عمل شبيه تنش زدايي مراقبه اي كه تصويرسازي زنده ناميده مي شود .

اثربخشي آموزش تنش زدايي :

- درمـان فشارخـون بالا
- در مـان درد مزمـن
- تنش زدايي مبتني بر مراقبه دركاهش استرس ، اضطراب ، تـرس و فشارخـون بالا
- مراقبـه آگاهـانه درد مـزمن

| مشكل | روش تنش زدايي | تأثير |
|---|---|---|
| فشارخون بالا | چندين نوع از آموزش تنش زدايي | مؤثر در فشارخون خفيف نه به شدت تاثير دارو |
| سردرد تنشي | تنش زدايي عضلاني تدريجي | مؤثرتر از دارونما مشابه تاثير پسخوراند زيستي |
| اضطراب | تنش زدايي مبتني بر مراقبه | مشابه تاثير آموزش تنش زدايي |
| درد مزمن | مراقبه آگاهانه | بهتر از درمان جسمي يا طبي |
| اضطراب | مراقبه آگاهانه | مؤثرتر در 90 درصد از بيماران |
| تهوع و اضطراب ناشي از شيمي درماني | تجسم هدايت شده همراه با تنش زدايي تدريجي | مؤثرتر از فقدان درمان |
| درد سوختگي | تجسم هدايت شده همراه با تنش زدايي | مؤثرتر از ساير تركيب هاي تنش زدايي |

اثربخشي روش هاي تنش زدايي

منبع : ال برانون و جي. فيست1997

## 7- پسخوراند زيستي

* در مورد وضعيت نظام زيست شناختي خود
* شامل علايم
  - شنيداري
  - لامسه
  - ديداري
* كنترل « EEG »
* براي اندازه گيري استرس ( ر.ك. فصل8 )
* اغلب نيازمند به تكنولوژي گرانقيمت و كاركنان آموزش ديده .

✵پسخوراند زيستي هم در مورد تسكين درد و هم در مورد استرس مؤثر است .

## 8- تغيير رفتار :

✵ بر اساس روشهاي شرطي سازي عاملي ←—— هدف شكل دادن يا تغيير رفتارها نه احساسات همراه آن .

ارزيابي تغيير رفتار :

✵ در پيشرفت حركتي بيماران دردمند مؤثر است .

## 9- درمان رفتاري- شناختي:

- تأكيد بر استفاده از تقويت كننده هاي دروني ( نظير خود تقويت كننده ها ) براي تغيير شناخت و رفتار
- مبتني بر پايه تحقيقات اليس ( 1962 ) درمورد درمان عقلاني - عاطفي و تحقيقات بنـدورا ( 1977 ) در مورد خود - كارآمدي

## ارزيابي درمان رفتاري- شناختي :

- ارزيابي اثربخشي اين درمانها بدليل نمونه ها ، روشها و شيوه هاي متفاوت مشكل است .
- تمايل به ايجاد تغييرات كوتاه مدت كه از نظر ايجاد بهبودهاي دايمي در كاهش درد موفق تر بوده است .
- در تركيب با ساير روشها مانند درمانهاي تنش زدايي مؤثرتر است.

## رويكردهاي چند وجهي :

* تركيب درمـانهاي مختلف و به كارگيري شيـوه هاي مختلف ارائـه ( ديداري ، شنيداري ، لامسه ) براي بيمار دردمند .
* درمـانهاي چنـد رشتـه اي : كلينيك درد
* كلينيكهاي درد رويكـرد چند رشته اي را بـراي درمـان درد اتخـاذ كرده انـد .

- ضرورتاَ فقط در مجموعه هاي درمانگاهي يا بيمارستاني عمل نمي كنند، بلكه در هر زمينه اي كه درد در آن كنترل و درمان شود اجرا مي گردد .
- هدف تمركز روي عوامل علّي يا تشديد كننده درد .

- وسعت درمان در كلينيك درد ، شامل بهبود جسمي و كنشهاي كسب زندگي
- همكاري با خانواده بيمار براي كمك به افزايش حمايت اجتماعي و ارتقاي خوش بيني در بيمار دردمند و كاهش دلتنگي ، اضطراب و رفتارهاي نقش بيمار .

فصل پنجم :

## ارتباط پزشك - بيمار

- رابطه بيمار- متخصص
- پذيرش توصيه پزشكي
- جنبه هاي روانشناختي بستري شدن
- آمادگي براي جراحي

## رابطه متخصص - بيمار

- سنگ بناي طبابت خوب و بخش بسيار مهمي در روانشناسي سلامت ( WHO ، 1993 )
- اختصاص 60 تا80 درصد تشخيص هاي پزشكي از طريق مصاحبه پزشكي ( WHO ، 1994 )

## پژوهش در مورد ارتباط پزشك – بيمار

- ☑ اهميت ارتباط خوب
  دانشجويان پس از شركت در دوره مهارت ارتباط با بيماران به علائم كلامي وغير كلامي بيماران حرفه اي تر شدند ، بهتر تشخيص مي دادند .
  ( ايوانز و همكاران 1991، موهر1992، فريدريكسون و بول1992، نقل ازWHO ، 1993 )
- ☑ فقدان نظر مشترك در مورد موفقيت يا عدم موفقيت فرايند مشاوره ، خوش بيني پزشكان
- ☑ از نظر افزايش پذيرش درخواست هاي پزشكي مهم است .
- ☑ تبادل اطلاعات

## 2- اثر اتباط ضعيف

در معاينه طبي گروهي از پزشكان طي 74 معاينه طبي از بيماران به عمل آوردند قابل توجه بود ، 23 درصد از بيماران نگراني هايشان را تمام و 69 درصد از پزشكان حرف بيماران را قطع و به سوي اختلال خاصي سوق مي دادند و بيماران فقط 18 ثانيه صحبت مي كردند ( بكمن و فرانكل ، 1984 )

تـوصيـه هاي WHO ( 1993 ) به پـزشكان در مـورد مشاوره هـاي پزشك – بيمار :

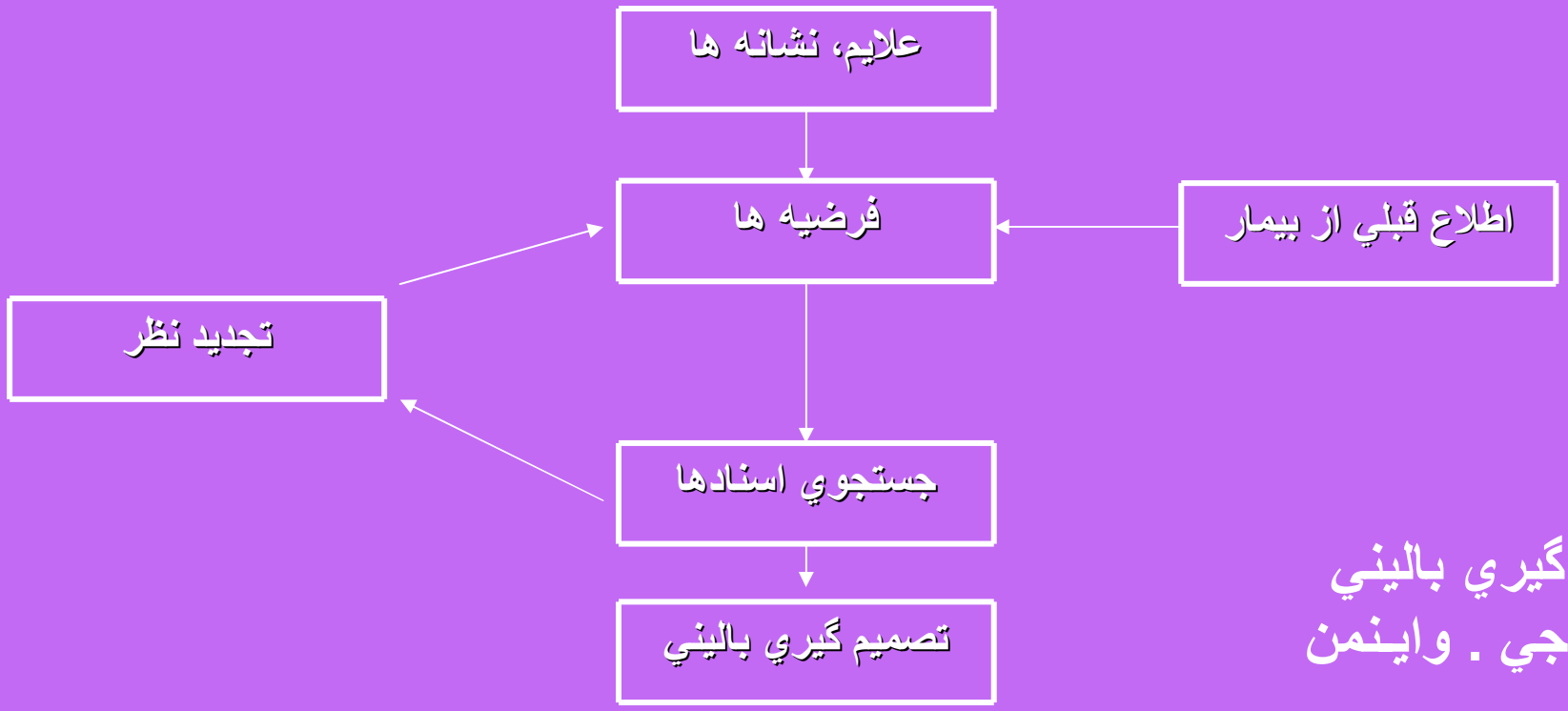
* سطح اطلاعات تخصصي را كه بـه كار مي برند بـازنـگري كننـد .
* از كلمات بالقوه وحشت آور نظير سرطان يا غطده حتي بـه مفهوم منفـي بازنـگري كننـد .
* بازنـگري در توصيه ها به بيماران جهت قطعيت آنـها و گمراه نشدن بيماران بااطمينان ساختگي ( كاذب ) و يـا نـاراحتي با شك آشكـار ذهنـي پـزشك

✓ تشخيص

- استفاده پزشكان در تشخيص آگاهانه از علائم و نشانه هاي ارائه شده توسط بيمار
- در حقيقت تصميم گيري باليني پزشك بيشتر شبيه به الگوي فرضي – استثنايي است كه از قبل تعدادي فرضيه در فرايند مشاوره ارائه و با سؤال هاي پزشك ، آزمون مي گردد ( واينمن ، 1987 )

مراحل الگـوي حل مسئله تشخيصي واينـمن 1987 :

* اطلاعات در مورد نشانه هاي بيمار
* فرضيه ها ( درباره علل و راه حل هاي احتمالي )
* جستجوي اسنادها * تجديد نظر * اطلاع قبلي از بيمار

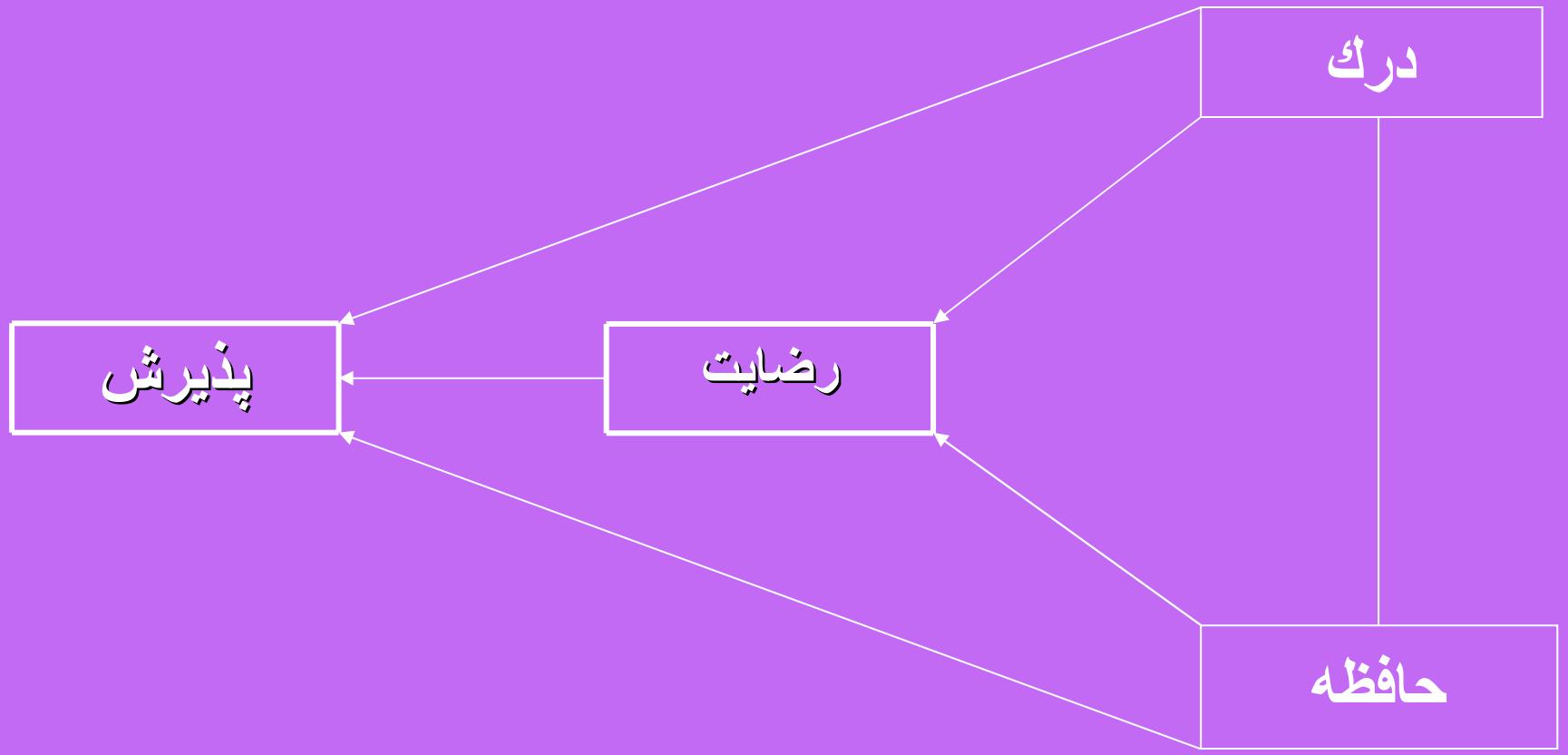



تصميم گيري باليني

منبع : جي . واينـمن

## آثار تغييرپـذيري پزشك :

- كسب اطلاعـات متفـاوت در مـورد نشانـه هاي بيمـار
- ارائـه فرضيـه هاي متفاوت در مورد علل بيماري و روش هاي درمـاني
- كسب اسنـادهاي متفاوت از وضعيت پزشكي بيمار بـراي تأييد يا رد فـرضيـه ها
- نشان دادن درجات متفاوتي از سوگيري بـراي تأييد تشخيص اوليـه
- در نـهايت رسيدن بـه تصميم هاي درمـاني متفـاوت




ارزيابي الگوي پذيرش « لي »

1- تحقيقات مهمي را ايجاد كند .

2- مشاهدات را سازماندهي كرده و توضيح دهد .

3- در پيش بيني و تغيير رفتار، متخصص را ياري دهد .

## رضايت بيمار

نارضايتي از جنبه هاي مختلف مشاوره متخصصان سلامت به ويژه :

- ☑ جنبه هاي عاطفي ( مثل فقدان درك و حمايت هيجاني )
- ☑ جنبه هاي رفتاري ( مثل تجويز دارو ، توضيح كافي )
- ☑ صلاحيت ( مثل مناسب بودن ارجاع ، تشخيص )

## درك بيمار

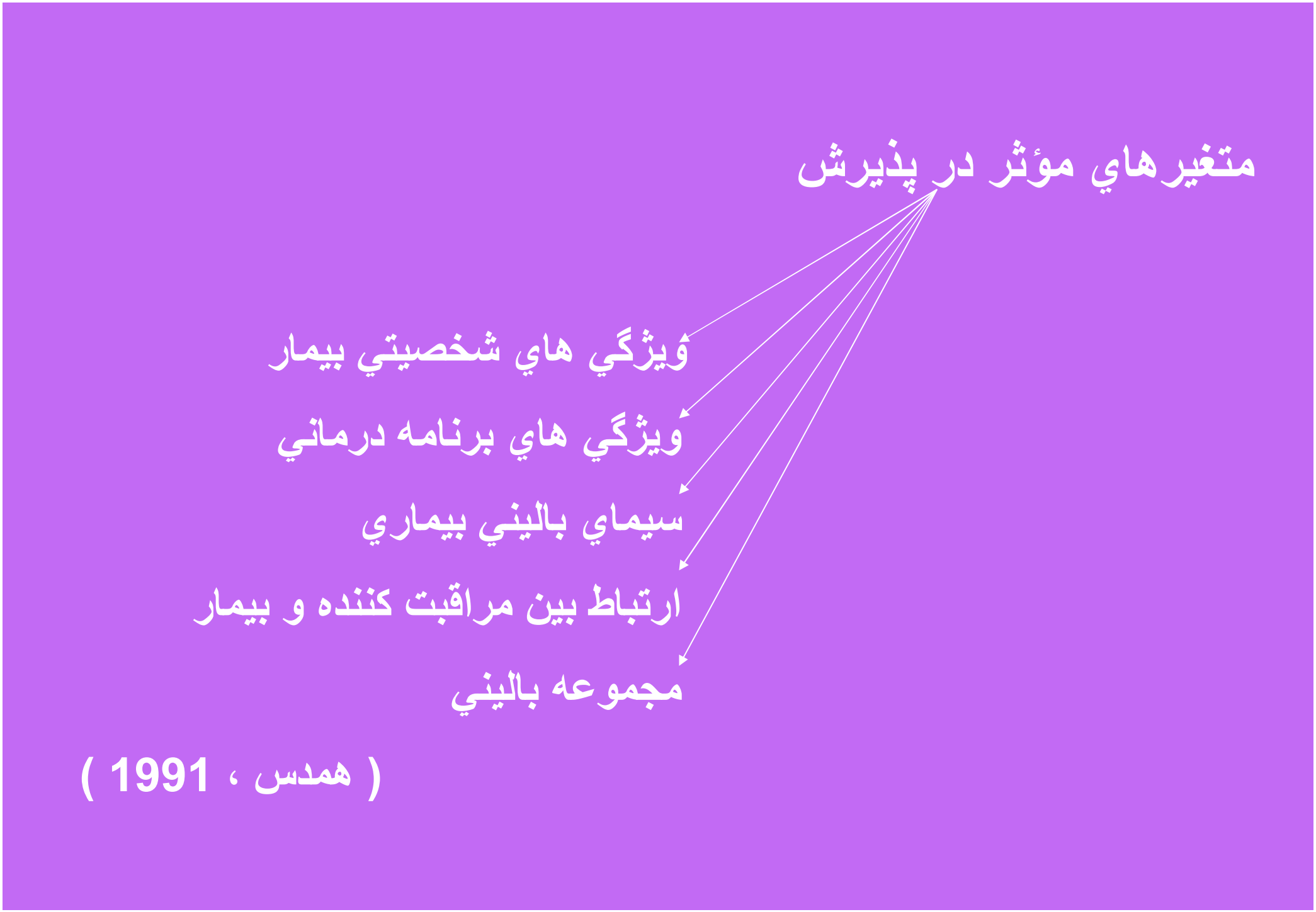
- ☑ درك بيمار از ماهيت بيماري خود —— پذيرش برنامه درمان پيشنهادي و فرايندهاي مرتبط يادآوري بيمار
- ☑ گزارش رضايت كامل از مشاوره و درك خوبي از بيماري

## يادآوري بيمار

☑ گزارش رضايت كامل از مشاوره و درك خوبي از بيماري

عوامل روانشناختي مؤثر در افزايش يادآوري اطلاعات در پذيرش ( لي ، 1989 ):

- كاهش اضطراب
- افزايش دانش پزشكي
- سطح هوش بالاتر
- اميت و فراواني اظهارات
- اثر تقدم


متغيرهاي مؤثر در پذيرش
ويژگي هاي شخصيتي بيمار
ويژگي هاي برنامه درماني
سيماي باليني بيماري
ارتباط بين مراقبت كننده و بيمار
مجموعه باليني
( همدس ، 1991 )

## ابعاد روانشناختي بستري شدن :

- بروز تغييرات در برنامه معمول روزانه و از دست دادن امور خصوصي و استقلال
- سردرگمي بيماران از دورنماي بستري شدن از لحظه پذيرش و نگراني از نقش اجباري كه بايد ناتمام پشت سر بگذارد ، اضطراب و افسردگي
- نگراني از نتايج آزمايش يا جراحي ( بي خوابي ، كابوس هاي وحشتناك ، ناتواني در تمركز حواس ) ( تيلور ، 1995 )

آمادگي براي جراحي ——— فيزيولوژيكي
روانشناختي

- انواعي از درجه بندي هاي باليني( مثل درجه بندي اضطراب )، نشانه هاي جسماني ( مثل فشارخون ) ، تجويز دارو قبل از عمل ( مثل مسكن هايي كه درد را كاهش مي دهند ) .
- مهمترين اقدام ——— بيان اطلاعات به بيمار در مورد : شيوه عمل ( زمان ومدت ) ، اطلاعات حسي ( ماهيت و مدت درد ) .
- ارائه دستورهايي در مورد رفتارهاي مؤثر در بهبودي ( مانند استراحت در بستر، تمرين هاي ورزشي سبك) و رفتارهاي پرهيزي(خارش ، سيگار كشيدن)
- آگاهي از تفاوت هاي فردي در آماده سازي براي جراحي مفيد است .
( پيتز و فيليپس ، 1998 )

## فواید آماده سازي مؤثر براي جراحي :

1- فيزيولوژيكي ←— كاهش استرس ←— كاهش برانگيختگي دستگاه عصبي سمپاتيك و پيشرفت هاي عملكرد « دستگاه ايمني »

2- روانشناختي ←— كاهش اضطراب و افسردگي و افزايش سطح مهار شخصي ←— بهبود مؤثر

# فصل ششم :

## عوامل روانشناختي بيماري

- جسم وذهن در سلامت
- نقش علل روانشناختي در مشكلات مزمن سلامت
- مشكلات بيماري هاي مزمن
- بيماري لاعلاج
- سازگاري با بيماري

## مسئله جسم و ذهن در سلامت

* تمركز الگوي پزشكي بر علل جسمي براي مشكلات سلامت مثل :
  - ميكروب ها
  - ژن ها
  - مواد شيميايي

⇦ در نتيجه توصيه درمان هاي جسمي ( مثل داروها )

* بزرگترين چالشها در روانشناسي سلامت ——الگوي زيستي ، رواني، اجتماعي و عوامل غيرجسمي مؤثر در سلامت

## ذهن:

- ☑ مفهومي است كه توانـايي مشاهـده پذيري و آزمـايش پذيري را ندارد و لذا برخي از رفتارگرايان وجود آن را انكار مي كنند .
- ☑ روانشناسان سلامت معتقدند به هنگام خطر ، قدرت ذهن خود را نـاديده مي گيريم .

# نقش علل روانشناختي در مشكلات مزمن سلامت

- مشكلات مزمن سلامت : بيماري هاي درمان ناپذير ولي كنترل پذير توسط بيمـار و متخصص سلامت ( سرطان ، آرتروز ، ديابت ) .

- كمك روانشناسي در سه بيماري مهم :

سنـدرم نقص اكتسابي ، ويـروس نقص ايمني انسان ـــــ ايدز ( AIDS )

سرطان

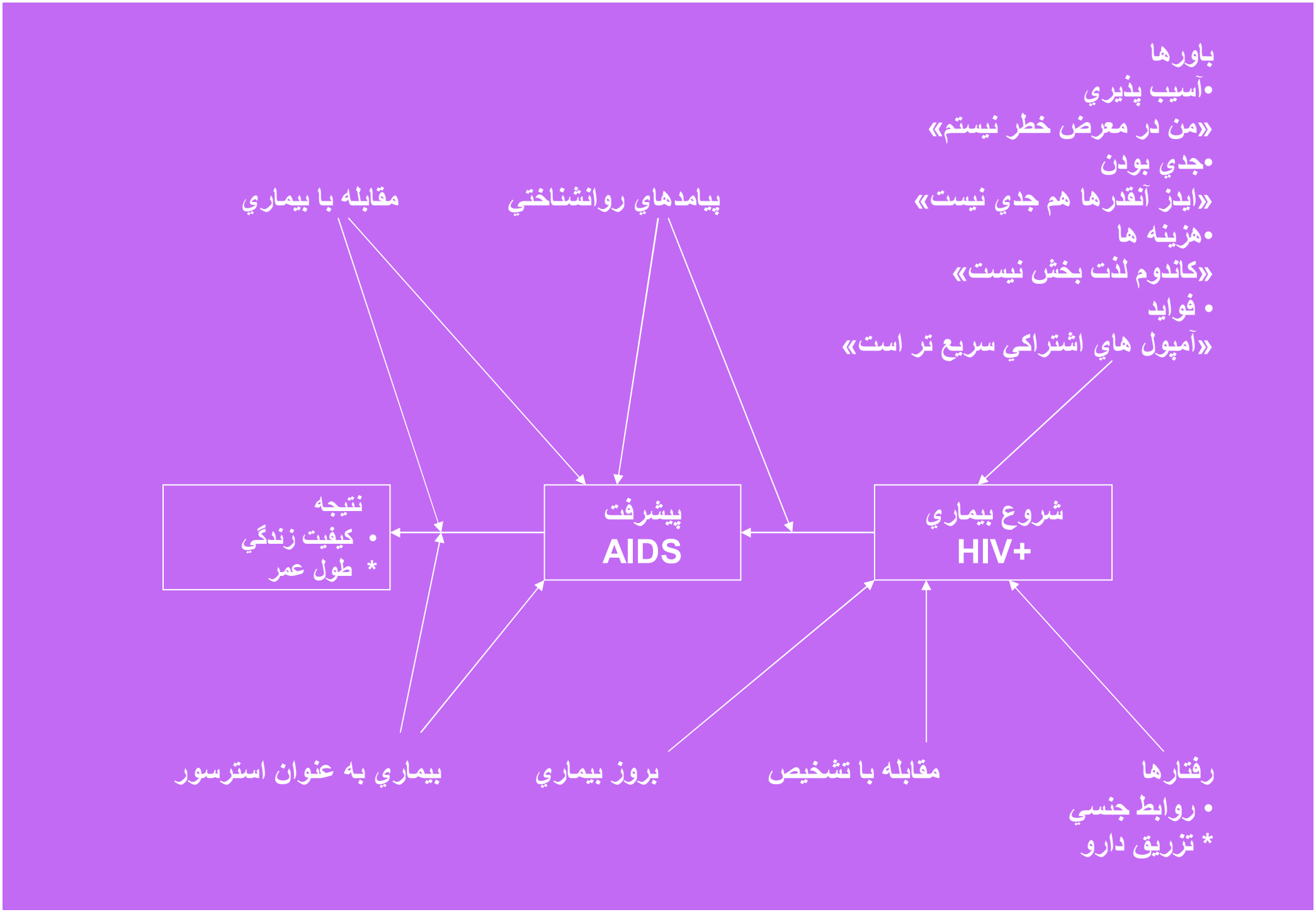
بيمـاري كرونـري قلب ( CHD )

- اولين مورد سندرم نقص ايمني اكتسابي ايدز به سال 1981 در آمريكا تشخيص داده شد .

## سندرم نقص ايمني اكتسابي ( ايدز )

- بيماري مخصوص « همجنس خواهي » و « سندرم نقص ايمني مربوط به هم جنس خواه » شناخته شد .
- پاسخي به استفاده بيش از حد از داروهاي آرامبخش ، يا عرضه بيش از حد مني و متمركز بر سبك زندگي هم جنس بازان .
- مبتلا شدن هموفيلي ها به ايدز از سال 1982
- ويروس ايدز به طور انحصاري از طريق تبادل مايعات بدني حاوي سلول مني و خون انتقال مي يابد .
- تشخيص نوع 1 ويروس نقص ايمني انسان ( 1984 ) .

- شناسايي نوع 2 آن در آفريقا ( 1985 ) به طور انحصاري با تبادل مايعات بدن حاوي سلول مني و خون انتقال مي يابد.
- عامل ويروس دخالت كننده در ايدز يك ويروس پس رونده است ( شامل اسيد ريبونوكلئيك ( RNA ) كه مي تواند ماده ژنتيك خود را ( RNA ) به DNA اسيد سلول هاي ميزبان خود تبديل كند و باعث سرطان يا HIV شود ) .
- ويروس پس رونده به ويروس نقص ايمني انسان(HIV) معروف است .
- مدت بين مبتلا شدن به ويروس و بروز نشانه هاي ايدز متغير است . در برخي از افراد سريع بروز مي كند و برخي 8 يا9 سال يا بيشتر علائم نشان نمي دهد .


باورها
•آسيب پذيري
«من در معرض خطر نيستم»
•جدي بودن
«ايدز آنقدرها هم جدي نيست»
•هزينه ها
«كاندوم لذت بخش نيست»
• فواید
«آمپول هاي اشتراكي سريع تر است»
مقابله با بيماري
پيامدهاي روانشناختي
نتيجه
• كيفيت زندگي
* طول عمر
پيشرفت
AIDS
شروع بيماري
HIV+
بيماري به عنوان استرسور
بروز بيماري
مقابله با تشخيص
رفتارها
• روابط جنسي
* تزريق دارو

## نقش روانشناسي در مطالعه AIDS وHIV

- HIV اغلب بـه علت رفتـارهاي مردم منتقل مـي شود مـانند : روابـط جنسي و استفاده مشتـرك از آمپول افراد آلوده .
- عوامل در نظر گرفتـه شده توسط الگويـي از آگـدن ( 1996 ) كه نقش بالقوه روانشناسي درHIV وAIDS را نشان مي دهد ، خلاصه شده اند.

## آسيب پذيري

- هر شخصي كه در معرض ويروس HIV قرار بگيرد HIV مثبت نيست .
- عوامل روانشناختي ممكن است بر آسيب پذيري شخص براي HIV مثبت شدن تاثير بگذارد .
- خوش بيني هاي غيرواقعي يكي از علل افراد در معرض خطر ( اعتقاد بر اينكه براي آن ها اتفاق نمي افتد ) ( واين اشتاين ، 1984 )

در فعاليت هاي آموزشي سلامت

☑ با تشويق تمرين رابطه جنسي سالم ( با استفاده از كاندوم )

مي توان نگرش ها و رفتارها را تغيير داد ، هر چند ارتقاي رابطه جنسي سالم پيچيده تر از افزايش دانش و عرضه خدمات صرف است .

# پيشرفت بيماري

عوامل روانشناختي مؤثر در تسريع و تكثير ويروسHIV

– داروهاي تزريقي

- ويـروس تبخـال

- استرس يا پريشاني

( سودروسكي و همكاران ، 1984 )

## طول عمر

- هيـچ فـردي بطه خـاطر ابتـلا بـه HIV از ايـدز نمي ميـرد .
- عوامل و مداخلات روانشناختي از طريق تشويـق بـاورهاي مثبت و ارتقاي رفتارهاي سالم، طول عمر را افزايش مي دهد .
- رفتارهاي تيپ C به طول عمر بستگي نـدارد گرچه اظهار خشم يـا خصومت بـه نتيـجه مثبت كمك مـي كند .

( سولومون و همكاران ، 1987 ، به نقل از آگدن ، 1996 )

## علل پيش بيني در بقاي بيماران مبتلا به ايدز :

- وضعيت سلامت عمومي در خط پايه
- رفتارهاي سالم
- سطح « سرسختي » ( شيوه مقابله بر اساس داشتن سطوح بالايي از « مهار » شخصي ؛ « تعمد » (يافتن معنايي براي كار، ارزش ها و روابط شخصي ) و « مبارزه جويي » (نگاه به رويدادهاي بالقوه استرس زا ، به عنوان يك مبارزه ) .
- ميزان حمايت اجتماعي (حمايت روانشناختي از سوي دوستان و... )
- رفتار تيپ « C » ( از خود گذشتگي ، فقدان تظاهرات هيجاني )
- راهبردهاي مقابله اي ( متمركز بر هيجان/ مشكل و... )

( سولومون و همكاران ، 1987، به نقل از آگدن ، 1996 )

## بيماري كرونري قلب

- « تصلب شرائين » ( تنگ شدن شريانـهاي كرونـري كه خون قلب را تامين مي كنند) ——نارسايي جريان اكسيژن و تغذيه قلب ——درد مكرر (آنژين قفسه صدري) ——« آنفـاركتوس ميوكارد » / يا حمله قلبي .
- شيوع در مـردان و افراد پير ( علت مرگ 33% مردان زير65 سال و 28% همه مرگها )
- زمينـه خـانوادگـي دارد .
- علل خطرآفرين : فشارخون بالا ، ديابت ، سيگار كشيدن ، چاقي ، پائين بودن سطح فعاليت جسمي .

## نقش روانشناسي

### پيش بيني و تغيير عوامل خطرآفرين رفتاري

- كمك به افراد براي ترك سيگار زيرا : كشيدن 20 سيگار در روز ، خطر ابتلا به بيماري كرونري قلب را در ميانسالان سه برابر افزايش مي دهد ، لذا ترك استعمال دخانيات مي تواند خطر حمله قلبي دوم را تا 50 درصد كاهش دهد. ( آگدن ، 1996 ) .
- تغييرات برنامه غذايي مصرف با كاهش چربي اشباع شده وافزايش فيبر به جلوگيري از حمله قلبي كمك مي كند .

- عوامل ژنتيكي ، چاقي، مصرف بيش از حد الكل ، مصرف بيش از حد نـمك مي تواند بر فشار خـون بالا (عامل خطر براي بيمـاري كرونري قلب ) تأثير بگذارد .
- استرس زياد با حمايت اجتماعي كم و مهار ادراك شده پايين تر در بيماري قلبي دخالت دارد ( كاراسك و تئورل ، 1990 )
- افراد داراي الگوي رفتاري تيپA ( رقابت شديد ، عجله و كينه توزي ) بيشتـر از نيم رخ B ( آرام و ساكت تر و بدون عجله ) در معرض خطر هستند . ( فريدمن و روزنمن ، 1959 )

## روانشناسي و توانبخشي بيماران كرونري قلب

- تشويق اين بيماران با تغيير عوامل خطرآفرين ( عدم فعاليت ، رفتار تيپA ، سيگاركشيدن و برنامه غذايي ) در برابر حمله قلبي عود كننده
- كاهش خطرات با برنامه تغيير رفتار ( فريدمن وهمكاران ، 1986 )

# بيماري علاج ناپذير

☑سرطان : توده بدخيمي كه ناشي از تقسيم غيرعادي و كنترل نشده سلول ها بوده ، به بافت هاي مجاور حمله كرده و آنها را از بين مي برد.

☑ دو نوع توده : « خوش خيم » كه در سراسر بدن پخش نمي شوند و « بدخيم » كه نشان دهنده گسترش ميكروب بيماري اند .

☑ انواع سلول سرطاني

- كارسينوما ← 90% تمام سلولهاي سرطاني كه ريشه در بافت دارند .
- سركوما ← ناشي از بافت پيوندي
- لوسمي ← ناشي از بافت خون

☑ شيوع سرطان

زنـان ←——— بيشتـر سرطان سينـه 20% ميـزان مرگ وميـر

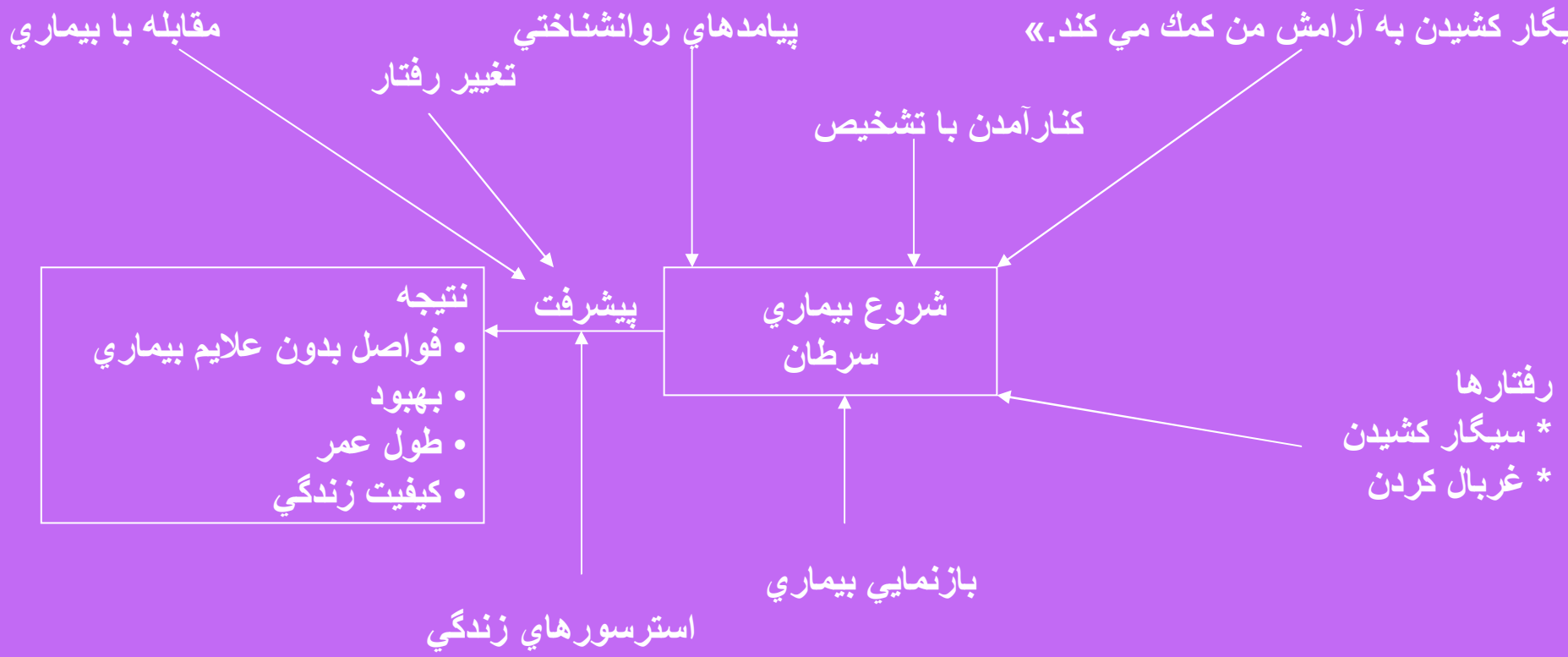
مردان ←——— بيشتـر سرطان ريـه 36% ميـزان مرگ وميـر

☑ در انـگلستان ، سرطان ها و بيماري هاي كرونري قلب مهم ترين علت اصلـي مـرگ

☑ كـشيدن سيگـار ———→ سرطان ريـه 85% سرطـان ها بـالقوه قابـل پيشگيـري است .

باورها
• آسيب پذيري
«من سرطان ريه نمي گيرم»
• جدي بودن
«سرطان ناحيه گردن جدي نيست»
• هزينه ها
«آزمايش سرطان دهانه رحم خجالت آور است»
* فواید
«سيگار كشيدن به آرامش من كمك مي كند.»

نقش روانشناسي در سرطان
منبع : جي آگدن ، 1996



# نقش روانشناسي در سرطان

☑ به عنوان مسكن در مرحله رشد سرطان و مؤثر در محدود كردن آن .

## شروع و پيشرفت سرطان :

تأثير رفتار

30 % از سرطان ها به استفاده از تنباكو
35 % از سرطانها به برنامه غذايي
7 % از سرطانها به رفتار جنسي و توليدمثل
3 % از سرطانها به الكل
( اسميت و جاكوبسن ، 1989 )

نقش استرس ( ر.ك. فصل8 )

✓ساير عوامل روانشناختي مؤثر در سرطان :

✵ سطح مهار ادراك شده روي استرسورها ، سبك هاي مقابله اي ، استرس خفيف مزمن ( نه افسردگي باليني ) ، شخصيت تيپc و نيم رخ سرسختي پايين.

✓پاسخ هاي روانشناختي به سرطان :

✵پاسخ هاي هيجاني شامل : افسردگي شديد ، اندوه ، فقدان كنترل ، تغيير شخصيت ، خشم و اضطراب ، در 20% موارد

✵ پيش بيني كننده هاي آشكار : سابقه روانپزشكي ، فقدان حمايت اجتماعي ، سن و فقدان روابط صميمي

✓ پاسخ هاي شناختي

✵ روحيه « مبارزه طلبي » ( كاهش اضطراب و افسردگي )

## راهبردهاي روانشناختي براي مقابله :

☑ ارتباط « درماندگي آموخته شده » و « اشتغال خاطر نگران كننده » با خلق پائين ( برخلاف باور جبرگرايي : سرطان من ؛ اجتناب ناپذير است ).

☑ سه راهبرد زنان مبتلا به سرطان سينه :

- اشتغال به جستجوي معنا براي چگونگي ايجاد سرطان ( طيفي از علل موروثي تا استرس )
- باور به توانايي كنترل بيماري يا بازگشت آن لذا داشتن يك حس برتر در روز بيماري
- اعتلا خود با مقايسه اجتماعي خود با افراد مهم زندگي براي تحليل بيماري

- نظريه سازش شناختي تيلور ← تركيبي از معنا ، برتري و اعتلا خود ، راهبرد مقابله اي مؤثر براي بيماري سرطان است .
- روانشناسي در تسكين نشانه هاي سرطان و ارتقاء كيفيت زندگي سهيم بوده است .
- « مقايسه اجتماعي نزولي » خود با افرادي كه بدتر بودند ← افزايش عزت نفس و بهبود باورها در مورد بيماري شان .

- ✓ مداخلات رواني – اجتماعي :

كنترل درد
حمايت اجتماعي
معالجه تهوع و استفراغ
مشاوره درباره تصوير بدن
( كيفيت زندگي و مشاوره اندوه )
راهبردهاي سازش شناختي
( ارتقاي ارزشي خود )
درمان كل نگر ( تنش زدايي ، تصوير ساز ذهني و ورزشي )

( سيمونتون و سيمونتون 1975 )

## طول عمر و افزايش دوره بدون بيماري

- عدم رابطه مستقيم بين عوامل روانشناختي و طول عمر
- زناني كه روحيه مبارزه طلبي يا انكار نسبت به سرطان خود ( سينه ) داشتند به ميزان زيادي دوره عادي از بيماري طولاني تري نسبت به گروه درمانده داشتند . ( گرير و همكاران ، 1979 )
- افراد تيپ C ( مستعد سرطان ) با نوع شخصيت تعارض- اجتنابي / سركوب كننده - هيجاني كه درمان شناختي- رفتاري متمركز بر استرس دريافت كردند ، داراي مرگ و مير كمتري بودند ، لذا مداخلات روانشناختي مي تواند طول عمر را افزايش دهد .

## سازگاري با بيماري

- فرايند كنارآمدن بيماران با بيماري خود در طي دوره اي از زمان براي مثال : كنار آمدن با ساختن معنايي شخصي براي بيماري و درك ماهيت بيماري شان ( علل ، عوارض و معناي ضمني )
- بيماري مزمن مستلزم فرايند مشترك سازگاري است .
- بيماري مزمن طولاني مدت مانند ايدز، سرطان ، بيماري هاي قلبي با تغيير نگاه بيماران نسبت به خودشان همواره بحران هايي را در زندگي افراد پديد مي آورند و منجر به سختي و اختلال در پويايي خانواده مي شوند .
- مداخلات حائز درمانهاي روانشناختي و اجتماعي به جاي درمان هاي جسمي صرف ، باارزش ترين انتخاب از نظر بهبود و رضايت بيمار

# فصل هفتم :

## سبك زندگي و سلامت

- جنبه هاي سبك زندگي
- ورزشي و تغذيه
- چاقي و اختلالات غذا خوردن

## جنبه هاي سبك زندگي

- درك سلامت و روانشناسي سلامت با تمركز بر فقدان بيماري كامل نيست .
- تأكيد روانشناسي سلامت معاصر بر فواید حالت هاي مثبت سلامت و حوزه هاي مرتبط با ارتقاي سلامت ( مانند اولز و سيمنت ، 1995)
- تمركز بر مطالعه سبك زندگي براي درك ما از سلامت

- اهميت عوامـل سبك زنـدگي ماننـد انجـام منـظم ورزش و درپيـش گرفتن بـرنامه غذايـي سالم و زيان عواملي مانند كشيدن سيگار بـراي سلامت زنـدگي
- حـدود 50% مـرگ هاي زودرس در كشورهاي غربـي مربوط به سبك زندگي
- افراد سيگاري 5 سال اميد به زندگي خود را از دست مي دهند.و افراد داراي سبك زندگي نشسته ( غيرفعال ) 2 تا3 سال اميد به زندگي خود را از دست مي دهند .
- متخصص تـغذيه مي توانـد ملاك هاي سبك زندگي سالـم را تـرسيم نمايـد .

- تـأكيد روانشناس ورزشي بـر اهميت ورزش منـاسب و منظـم بـراي نـگهداري تنـاسب جسمـي و پـرورش اعضـاء هـوازي
- ما بايد سبك زندگي را در نظر بـگيريم نه رفتارهاي خـاص سلامت را
- تغييـر گرايش ها و شيوه در سلامت ، ممكـن است تحت تأثير عوامل فرهنـگي و خرده فرهنـگي وسيعتـري قرار گيرنـد مثلا خـانواده از منـابع اصلي اطلاعات بـراي غذا و بـرنامه غذايي ماست . يـا اثـر تبـليغات تجـاري تلويزيـون بر انتخـاب غـذاي كودكان و سبـك زنـدگي

## ✓ پژوهش در سبك زندگي

سبك زندگي سالم مي تواند بر مدت زندگي تأثير بگذارد .
هفت تمرين مربوط به سلامت :

1- هفت تا هشت ساعت خواب در شبانه روز
2- تقريباَ هر روز صبحانه خوردن
3- نخوردن يا بندرت خوردن بين وعده هاي اصلي غذا
4- به طور معمول در وزن متناسب با قد يا نزديك به آن بودن
5- هرگز سيگار نكشيدن
6- استفاده نكردن از الكل
7- فعاليت جسمي منظم

( بلوك و برسلو ، 1972 )

# ورزش و تغذيه

✓ ورزش جسمي :

◉ ورزش در گسترده ترين معناي خود صدها نوع از فعاليت هاي مختلف را در برمي گيرد .

◉ پنج نوع ورزش متفاوت از نظر فيزيولوژيكي

- ورزش ايزومتريك
- ورزش ايزوتونيك
- ورزش ايزوكينتيك
- ورزش بي هوازي
- ورزش هوازي

( برانون و فيست ، 1997 )

✓ ورزش ايزومتريك :

◉ بدن حركت مي كند ، اين شيوه ورزشي گروهي از ماهيچه ها را تقويت مي كند ، هر چند براي وضعيت كلي مؤثر نيست .

✓ ورزش ايزوتونيك :

◉ نيازمند انقباض عضلات و حركت مفاصل

◉ مبناي شيوه هاي بدنسازي

◉ تأكيد بر پيشرفت ظاهر بدن نه پيشرفت تناسب و سلامت .

✓ ورزش ايزوكينتيك

◎ نيازمند اعمال فشار براي بلندكردن و تلاش اضافي براي برگرداندن به حالت اول
◎ نيازمند تجهيزات تخصصي
◎ براي پِيشرفت قدرت و تحمل عضله مؤثرتر از دو روش قبلي .
( پيپس و ويلمور ، 1975 )

✓ ورزش بي هوازي
◎ شامل كسب انرژي كوتاه و شديد ، بدون افزايش مقدار اكسيژن .
(دوي سرعت و بازي با توپ)
◎ باعث پيشرفت سرعت و تحمل ، لذا براي افراد داراي بيماري كرونر قلبي خطرناك

## ✓ ورزش هوازي

- ◉ به هر نوع ورزشي كه بـه مصرف اكسيژن بسيار زياد در دوره طولاني احتياج دارد . (مثل دويدن آهسته )
- ◉ ضربان قلب بـايد حداقل تا 12 دقيقه و ترجيحا 15 تا30 دقيقه در اين سطح افزايش يافته باقي بماند تا اين ورزش مؤثر گردد .
- ◉ توصيه : انجام معاينه پـزشكي قبـل از شروع بـرنامه ورزش هـوازي
- ◉ استفاده از يك برق نگار قلب مي تواند فعاليت غيرطبيعي قلب را طي ورزش مشخص كند .

✓ فواید جسمي ورزش :

◉ تناسب كلي ( اندازه گيري قدرت ماهيچه ، تحمل ماهيچه ، انعطاف پذيري و تناسب قلبي- تنفسي « هوازي » )

◉ تناسب عضوي و تناسب پويا كه با تجربه خودمان تعيين مي شود تفاوت دارد ( كونتزلمن ، 1978 )

◉ كمك به تقويت و ارتقاي تناسب پوياي ما و كمك به كنترل وزن

◉ پيشگيري از بيماري كرونري قلب ( از عوامل مهم مرگ در كشور انگلستان )

- ورزش هوازي بايد از مدت و شدت كافي برخوردار باشد تا اثرات واقعي خود را بگذارد ، افراد بايد 70 تا85 درصد حداكثر ضربان قلب را بدون وقفه براي دست كم 12 دقيقه ، سه بار در هفته اجرا كنند تا سلامت دستگاه قلبي عروقي را بهبود بخشند و خطر بيماري كرونري قلب را به ميزان زيادي كاهش دهند . ( كوپر ، 1982 )
- ورزش جسمي منظم ، باعث پيشگيري از سكته و پوكي استخوان و كمك به كنترل ديابت . ( برانون و فيست ، 1997 )

✓ فواید روانشناختي ورزش :

◉ علاوه بر فواید جسمي ورزش ، فواید روانشناختي عبارتند از :

- کـاهش افسردگـي
- کـاهش اضطـراب
- ایجاد محافظي علیه استرس( ر.ك.فصل8 )
- افـزایش عزت نـفس و خوب بـودن

- استفـاده از ورزش هاي هوازي و بي هوازي بـراي كمك بـه افراد ، به منظور مقـابله بـا اضطـراب
- بـه عنوان سپـري عليـه استـرس
- افزايش فعاليت سلولهاي طبيعي كشنده و افزايش درصد سلول هاي T
- ورزش و استرس هر دو بـاعث ترشح آدرنـالين و هورمـون هاي ديگر مـي شونـد .
- اثـر ورزش بـر عملكـرد قـلب
- استـرس زيـاد ، تنـاسب بدنـي پاييـن - افـزايش آسيب پذيـر شدن

- اثر تدافعي چشمگير مفيدي عليه استرس در مـردان جوان سالمي كه برنـامه ورزش هـوازي يا وزنه برداري را آغاز كرده بودند ، نيافتنـد . ( سينيـور و همكاران ، 1986 )
- ارتقـاي نـگرش هاي مثبت و افـزايش تصور از خـود و عـزت نفس
- در متاآنـاليز آثار ، دريافت كه رابطه مثبت معنـاداري بيـن ورزش و عزت نفس وجود دارد .( سانستروم ، 1984 )
- داشتن احساسات مثبت بيشتري در مورد شكل بدن و سلامت جسمي كه بـه احساس عـزت نفس كمك مي كند .
- تمركز نـگرانيهاي مـهم مربوط به ورزش ، روي خطرات بالقوه ورزش.

✓ تغذيه : رژيم غذايي و سلامت

◎ تـغذيه علت 60% سرطان هاي زنـان و40% سرطانـهاي مـردان آمريكا ( سيمون ، 1983 )

◎ رژيم هاي غذايي ضعيف اكثرا سرطان هاي اعضاء و جوارح ( مانند سرطـان هاي معـده ، رحم ، سينـه ، روده ها ، كبد ، دهان و... )

◎ نـقش خوردن غذاهاي حاوي مواد سرطان زا در بـروز سرطان مانند غـذاي فاسد ، عامـل خطـر در ابتلا بـه سرطـان معده .

- استفاده فراوان از نمك در برنامه غذايي انگلستان با فشار خون بالا و بيماري قلبي و عروقي مرتبط مي باشد .
- ميزان بالاي چربي و كلسترول با تصلب شرائين و با بيماري عروق كرونر قلب ، مرتبط بوده است .
- ارتباط بين مصرف چربي و سرطان سينه در زنان نسبت به بيماري عروق كرونر قلب از وضوح كمتري برخوردار است .

- ميزان ابتلا به سرطان سينه در زناني كه نيمي از كالري خود را از چربي به دست مي آوردند ، سه برابر بيش از حد متوسط
- مصرف بالاي چربي اشباع شده ، عامل خطر شناخته شده اي براي سرطان سينه وخيم نزد زنان مسن تر نه زنان جوان تر.
- برنامه غذايي در سرطان ريه در مردان نيز تأثير ضمني دارد .

- کلسترول زیاد ، احتمال افزایش دو برابری در سرطان ریه در مردان
- میزان کلسترول موجود در تخم مرغ در برنامه غذایي زیاد مي باشد .
- الکل ، در سرطان زبان ، لوزه ، مري ، کبد ، لوزالمعده تأثیر ضمني دارد . دائم الخمرها در مقایسه با افرادي که الکل مصرف نمي کنند پنج بار بیشتر احتمال ابتلا به سرطان لوزالمعده را دارند .

- مصرف ويتامينهاي A وC و سلنيوم ———كاهش خطر ابتلا به سرطان
- كمبود ويتامين A ———خرابي لايه محافظ معده
- بتاكاروتن نيز به عنوان محافظي عليه بعضي از انواع سرطان ها شناخته شده .
- ويتامين C و سلنيوم دو عاملي هستند كه باعث پيشگيري از بروز سرطان در انسان مي شوند .
- برنامه غذايي با فيبر زياد ، هم براي مردان و هم براي زنان در مقابل سرطان محافظت ايجاد مي كند .
- فيبر ميوه ها و سبزيجات بيش از فيبر غلات و ساير حبوبات ، روده بزرگ را عليه سرطان محافظت مي كند .
- مصرف ميوه حتي محافظت بيشتري عليه سرطان ريه ايجاد مي كند،لذا همه ما بايد در هفته سه تا هفت بار ميوه بخوريم .

✓ چاقي و اختلالات غذا خوردن :

◉ مفهوم مشكلي براي تعريف كردن
◉ درك چاقي از لحاظ معيارهاي شخصي ، اجتماعي و فرهنگي متفاوت .

فنون ارزيابي چربي بدن :

1- پرتونگاري مقطعي رايانه اي
2- تصوير طنين مغناطيسي ( MRI )

چاقي = شاخص جرم بدن كه با تقسيم وزن فرد به مجذور قد او محاسبه مي شود.

◉ چاقي هم با مشكلات جسمي سلامت و هم مشكلات روانشناختي همراه است.

## علل چاقي در نظريه ها :

- نظريه هاي فيزيولوژيك : براي چاقي ، حمايت ژنتيكي در خانواده ها وجود دارد .
- نظريه هاي ميزان سوخت و ساز : افراد چاق ميزان استراحت متابوليكي كمتري دارند .
- نظريه هاي رفتاري : افراد چاق تمايل كمتري براي فعاليت جسمي دارند و غذا بيش از مورد نياز دريافت مي كنند .

- اختلالات غذا خوردن ← بي اشتهايي رواني
  پرخوري
- بي اشتهايي ، اولين بار توسط يك پزشك لندني ، به نام « سر ويليام گول » در سال 1874 كشف شد كه با كاهش وزن افراطي كه از جانب خود شخص تحميل مي شود ، مشخص مي گردد ،گول اين بيماري را اختلال روانشناختي در نظر گرفت كه ريشه عصبي دارد .

- احتمال بروز بي اشتهايي در زنان 20 برابر بيشتر از مردان است .
- فقط افرادي بي اشتها تشخيص داده مي شوند كه وزن آنها حداقل 15% كمتر از حداقل وزن معمول و قاعدگي در آنها متوقف شده باشد .

✓ عوارض بي اشتهايي رواني و كاهش وزن :

- لاغري مرضي ( تحليل رفتن بدن )
- آسيب پذيري در برابرعفونت
- نشانه هاي سوء تغذيه
- تحريف در تصور از بدن

- هنجارهاي اجتماعي و عوامل روانشناختي ——— عوامل بالقوه اي براي اكتساب بي اشتهايي روانی .
- طرح ارتباط بين بي اشتهايي روانی و سندرم ترنر. در عوامل ژنتيكي از نظر عوامل فيزيولوژيكي،توجيه احتمالي بيانگر آن است كه هيپوتالاموس از عملكرد طبيعي بازميماند. اين مطلب با توجه به اين كه هيپوتالاموس هم غذاخوردن و هم عملكردهاي هورموني را كنترل مي كند تأييد مي شود .

- عوامل شخصيتي و پويايي خانواده در بي اشتهايي رواني :

  - نداشتن اعتماد به نفس
  - نياز به تأييد
  - وظيفه شناسي
  - كمال طلبي
  - احساس فشار براي موفق شدن

( تيلور ، 1995 )

- همچنين آسيب شناسي رواني والدين يا الكلي بودن آنها و به طور خاص رابطه مادر- دختر در اختلال غذا خوردن نقش دارد .

✓ درمان بي اشتهايي :

- تمركز روي رساندن وزن بيمار به سطح مطمئن
- فنون رفتاري بر اساس روش هاي شرطي شدن عاملي ( مثل پاداش دادن براي افزايش وزن با ملاقات اجتماعي )
- روان درماني براي افزايش عزت نفس و مهارت هاي ارتباطي .

پرخوري :

يك سندرم غذاخوردن كه با خوردن مكرر به مقدار زياد و سپس تلاش براي تخليه غذا از طريق استفراغ و دارو هاي ملين مشخص مي شود .

- استفراغ و استفاده از داروهاي ملين نيز مي تواند تعادل الكتروليت پتاسيم در بدن را بر هم بزند و منجر به كم شدن آب بدن ، بي نظمي هاي قلبي و عفونت هاي ادراي شود .
- در زنان جوان بيشتر ديده مي شود .
- شيوع افسردگي بين افراد مبتلا به پرخوري
- ارتباط دو اختلال پرخوري و بي اشتهايي رواني با كمبود ماده انتقال دهنده عصبي سروتونين

- نـداشتن اعتمـاد به نـفس و يا هـويت خـود
- درمـان پرخوري شامـل تـركيبي از دارو و درمان شناختي- رفتاري مناسب نيازهاي فردي شخص مبتلا به پـرخوري .
- استفـاده از داروهـاي ضد افـسردگي .
- سبك زنـدگي مي تواند تاثير بسزايي بر وضعيت سلامت ما در تمام مراحل پيشگيري وارتقـاي سلامت داشتـه باشـد .

# فصل هشتم :

## استرس و اداره آن

- ماهیت استرس
- فیزیولوژي استرس
- مقابله با استرس
- اداره استرس
- استرس و بیماري

## مـاهيت اسـترس :

- استـرس ، واژه مبـهمي است كه بـراي تـوصيف موقعيت ، شـي يـا شخصي كه بـاعث استـرس مـي شود ، احسـاس ها و پاسـخ هاي جسمي كه در فـرد ايجـاد مي گـردد و نتـايج حـاصل از آن بـه كـار مـي رود .
- استـرسورها : رويدادهايي هستند كه بهزيستي جسمي يا روانشناختي فرد را به خطر مي اندازنـد و مي توانند دروني ، بيروني يا اجتماعـي باشنـد .

- استرس : حالتي كه توسط استرسورها بوجود مي آيد و به ايجاد پاسخ هاي مربوط به استرس كه براي مقابله مؤثر با موقعيت ناخوشايندي برنامه ريزي شده اند منجر مي شود .

## فيزيولوژي استرس ( نقش دستگاه عصبي )

- عملكرد اصلي دستگاه عصبي ، يكپارچه كردن تمام دستگاههاي بدن با استفاده از يك شبكه ارتباطي براي تقويت اطلاعات در مورد شرايط دروني و بيروني به مغز و از مغز .

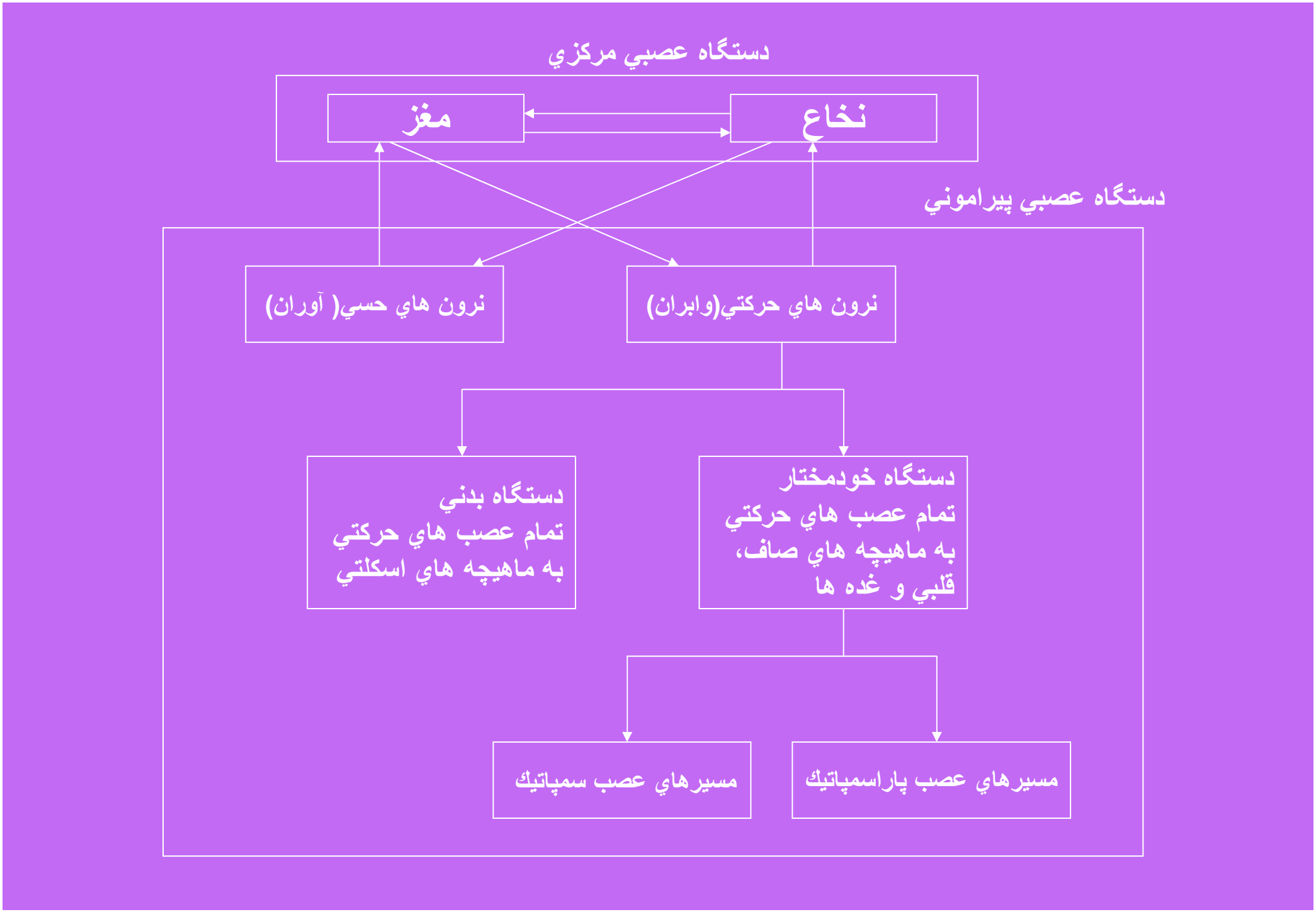
- عناصر اصلي دستگاه عصبي ، سلول هاي عصبي يا نرون ها هستند .
- اعمال هر نرون الكتروشيميايي است .

- بخش هاي دستگاه عصبي
  - مركزي ( CNS )
    - مغز
    - نخاع
  - پيرامونـي ( PNS )
    - خارج از مغز و نخاع قرار دارد .

- دستگاه پيراموني شامل
  - دستگاه عصبي بدني ( SNS )
  - دستگاه عصبي خودمختار ( ANS )

- دستگاه عصبي خودختار
  - دستگاه عصبي سمپاتيك ( بسيج نيروها براي پاسخ به موقعيتهاي استرس زا و هيجاني « پاسخ جنگ و گريز » )
  - دستگاه عصبي پاراسمپاتيك

- دستگاه عصبي پاراسمپاتيك
  - استيل كولين
  - نوراپي نفرين يا نورآدرنالين


دستگاه عصبي مركزي
مغز
نخاع
دستگاه عصبي پيرامونی
نرون هاي حسي( آوران)
نرون هاي حركتي(وابران)
دستگاه بدني
تمام عصب هاي حركتي
به ماهيچه هاي اسكلتي
دستگاه خودمختار
تمام عصب هاي حركتي
به ماهيچه هاي صاف،
قلبي و غده ها
مسيرهاي عصب سمپاتيك
مسيرهاي عصب پاراسمپاتيك

## نقش دستگاه عصبي درون ريز :

### ✵تفاوت دستگاه عصبي و درون ريز :

- در دستگاه عصبي مواد شيميايي انتقال دهنده عصبي نام دارد .
- در دستگاه درون ريز مواد شيميايي هورمون نام دارد .
- انتقال دهنده هاي عصبي سريع تر عمل مي كنند و آثار كوتاه مدتي دارند .
- هورمون ها آهسته تر عمل مي كنند و آثار طولاني تري دارند .
- دستگاه هاي عصبي و درون ريز ———هر دو عملكردهاي كنترلي و ارتباطي دارند و هر دو در جهت حفظ رفتارهاي يكپارچه و سازمان يافته كار مي كنند.

- ✓ در شرايط استرس ← هيپوتالاموس ← تحريك غده هيپوفيز ← آزادي ACTH ← عمل بر غدد فوق كليوي
- ✓ غده هيپوفيز و هيپوتالاموس ← همكاري با يكديگر براي توليد و تنظيم هورمون ← نمونه خوبي از وابستگي دو دستگاه عصبي و درون ريز ، غده هيپوفيز به هيپوتالاموس مرتبط است .
- ✓ غده هيپوفيز = غده مسلط
- ✓ آدرنوكورتيكوتروپيك ( ACTH ) نقش اساسي در پاسخ به استرس دارد .

- غدد فوق كليوي ⟸ بالاي هر يك از كليه ها
  - پوشش خارجي ⟵ قشر
  - پوشش داخلـي ⟵ هسته مركزي
- هسته مركزي توسط دستگاه عصبي سمپاتيك فعال ⟵ ترشح كاتكولامين
- كاتكولامين ⟵ آدرنـالين( اپي نفرين )
  - نورآدرنـالين
- گلوكوكورتيكوئيد يا هورمون استرس ⟵ شاخص فيزيولوژيكي استرس

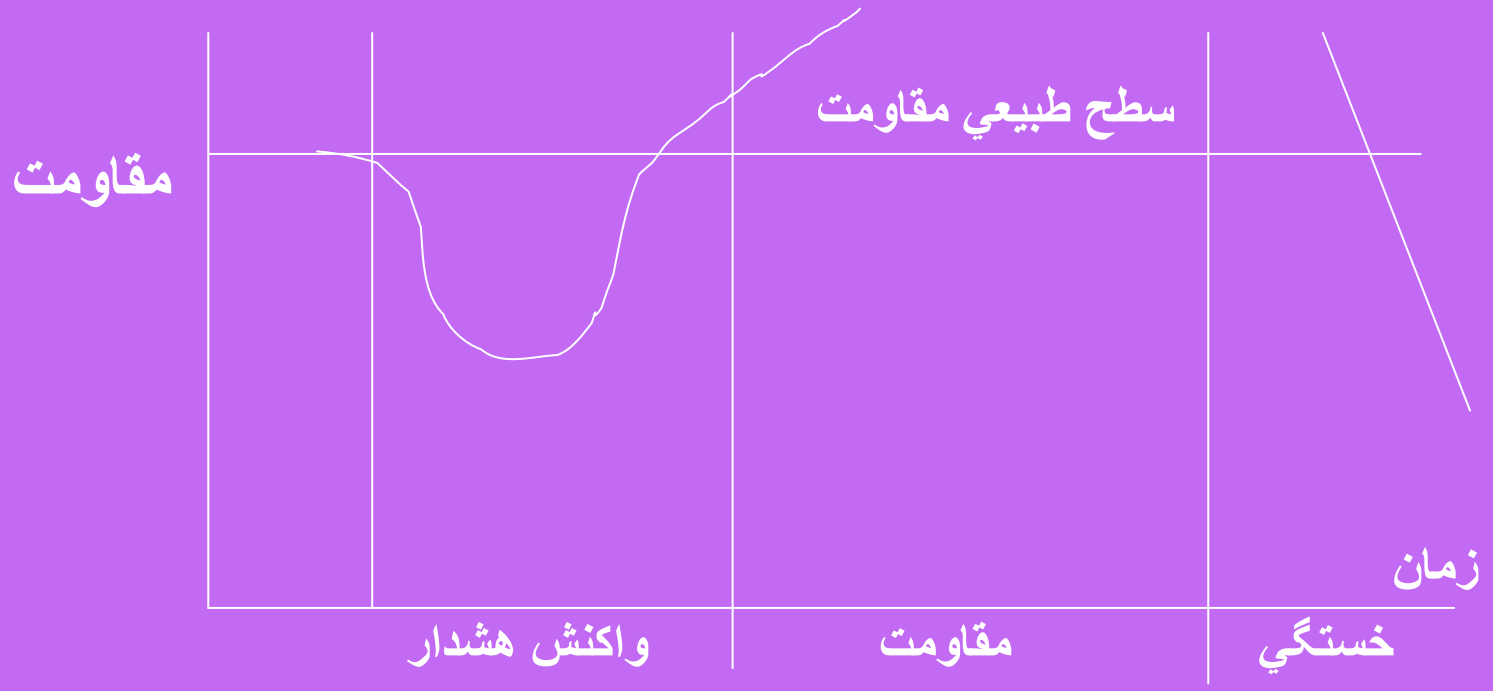
آدرنـالين فقط توسط هسته مركـزي غدد فـوق كليوي تـرشح مـي شود و 80% هورمون غدد فوق كليوي را شامل مي شود .

- فعال سازي دستگاه عصبي خودمختار سريع
- در حالي كه عمل دستگاه عصبي درون ريز آهسته تر
- پاسخ فيزيولوژيكي به استرس شامل ارتباط بخش سمپاتيك دستگاه عصبي خودمختار با دستگاه عصبي درون ريز و در تعامل با غده هيپوفيز و غدد فوق كليوي

## نظريه هاي استرس :

- به تعبير روانشناختي استرس ممكن است به محرك محيطي ، پاسخي به محركهاي محيطي يا تعاملي از هردوي آنها باشد .
- سندرم سازش عمومي سليه
  - واكنش هشدار
  - مرحله مقاومت
  - مرحله خستگي
- هانس سليه ، بيشترين تحقيقات را در مورد استرس از دهه 1930 تا زمان مرگش 1982 انجام داد و اولين كسي بود كه بين واژه استرس و استرسور تفاوت قايل شد .
- ارتباط زيادي بين استرس و بيماري جسمي وجود دارد .

سندرم سازش عمومي
منبع : پي . بن يارد1996



## واکنش هشدار :

- ◈ این واکنش اولیه ، بدن را در پاسخ به استرس ، با فعال کردن دستگاه عصبي خودمختار (ANS ) بسيج مي كند تا براي پاسخ جنگ و گريز آماده شود.
- ✵ مرحله مقاومت :
- ✓ سازش ارگانيسم با استرسور/ سازش بيشتر ، مقاومت طولاني تر
- ✓ طول دوره سازگاري وابسته به شدت استرسور و نحوه سازش پذيري ارگانيزم براي مقابله با استرسور
- ✵ مرحله خستگي :
- ✓ پايان توانايي مقاومت ارگانيزم و فروپاشي
- ✓ فعال شدن بخش پاراسمپاتيك دستگاه عصبي خودمختار و كمك به سمپاتيك در تعادل

## ارزيابي سندرم سازش عمومي سليه :

- توجيه جذابي براي سازگاري با استرس
- تأكيد فراوان بر عوامل فيزيولوژيكي به بهاي كم توجهي به عوامل روانشناختي
- انتقاد به سليه به علت عدم تشخيص صحيح نقش عوامل هيجاني و شناختي( تعبير و تفسير ) در استرس
- فراموشي بعد هيجاني كه مسئول تداوم پاسخ به استرس است . ( مسون ، 1975 )
- انتقاد به سليه به جهت استفاده از حيوانات براي تاييد تحقيقات خود در مورد پاسخ هاي انسان به استرس و در نتيجه ناديده گرفتن مشكلات برون يابي و علل منحصربه فرد انساني در درك و تفسير استرس

- الگوي تعاملي استرس( فولكمن و لازاروس ) ———— توجه به علل شناختي و هيجاني در توجيه استرس
- تفسير رويدادهاي استرس زا از خود رويدادها مهم تر
- كار با انسان ها به جاي حيوانات چون انسانها به خاطر سبك زندگي بيش از حيوانات در معرض انواع استرس هاست .
- ارزيابي استرس به عنوان ارتباط ويژه بين شخص و محيط

✵ سه شكل ارزيابي در برخورد با استرس( لازاروس و فولكمن ) :

1- ارزيابي اوليه
- ارزيابي نامربوط ← معمولا هيچ تاثيري بر هيجانهاي ما ندارند .
- ارزيابي ملايم – مثبت ← اين رويداد مفهوم خوبي دربرداشته.
- ارزيابي استرس زا ← رويدادي زيان بار ، تهديدكننده يا چالش آميز

2- ارزيابي ثانويه : از موقعيتي كه در آن قرار گرفته ايم به عمل مي آوريم و اين كار را با طرح اين سؤال كه چه طور به بهترين وجه مي توانيم با اين موقعيت برخورد كنيم انجام مي دهيم .

## 3- ارزيابي مجدد

- پاسخهايمان نسبت به موقعيت استرس زا با استفاده از تغيير اطلاعات موجود
- ارزيابي مجدد ممكن است استرس را افزايش دهد .
- ✓ ارزيابي الگوي تعاملي استرس :
- تأكيد بر دربرگرفتن خصوصيات فعال استرس وعلل روانشناختي ( مثل ادراك ) در فهم پاسخ استرس
- تأييد اثر ارزيابي بر استرس و نقش تغيير يا ارزيابي در مقابله با استرس .
- بيش از آن كه توضيحي باشد ، توصيفي است .

## مقابله با استرس:

- به عنوان يك فرايند و تغيير مداوم تلاش هاي رفتاري و شناختي براي تأمين نيازهاي ويژه داخلي و يا خارجي .

- دو نوع مهم ازمهارت هاي مقابله اي

متمركز بر مسئله

متمركز بر هيجان

## ارزيابي پژوهش در مورد روش هاي مقابله اي :

- اهميت راهبردهاي مقابله اي از جانب متخصصان سلامت و روبرويي با پذيرش عام
- تفاوت هاي فردي در اثربخشي روش هاي مقابله اي به پيش بيني هاي خاصي در مورد اين كه چه افرادي تحت چه شرايطي احتمال بيشتري براي بهبودي از بيماري خاصي را دارند،منجر مي شود.
- اثر سرسختي/ ساختار تشخيصي/ كنترل / تعهد و مبارزه جويي بر موفقيت راهبردهاي مقابله اي

اداره استرس :

1- با استفـاده از پسخوراند زيستي ، هيپنوتيـزم

2- تغيير رفتار ، مراقبه و روش هاي تنش زدايي

3- درمـان شناختـي و ورزش

تلقيح استرس :

▣ براي درمان درد و اداره استرس شامل ( ميشن بام و كامرون ، 1983 ) :

1- مفهومـي كـردن

2- كسب مـهارت ها

3- تمريـن ، دنبال كردن يا به كار بردن

1- مرحله مفهومي كردن :

◉ استفاده از يك مصاحبه شناختي كه در آن درمانگر شناختي با بيمار خود در جهت تشخيص و روشن سازي ماهيت استرس آنها كار مي كند .

2و3- مرحله كسب مهارت ها و تمرين :

◉ كاربرد مؤلفه هاي آموزشي و رفتاري براي ارتقاي خزانه مهارت هاي مقابله اي بيمار( مانند : يادگيري شيوه هاي جديد مقابله با استرس ) .

## ارزيابي روش هاي تلقيح استرس :

◉ مؤثر در موقعيت هاي متعدد استرس زا

◉ تلقيح استرس + تنش زدايي عضلاني تدريجي + بازسازي شناخت و جرأت آموزي ———كاهش رگه اضطراب و استرس

( كيس ليكا و همكاران ، 1994 )

## استرس و بيماري :

- ارتباط پيچيده بين استرس و بيماري
- بيماري و ناخوشي ممكن است توسط عواملي ازجمله عوامل ژنتيكي ، بيولوژيكي ، روانشناختي و سبك زندگي و حتي محيط اجتماعي ما به وجود آيند .
- ارتباط استرس، با طيفي از بيماريهاي جسمي و با خلق منفي و اختلالات خلقي مانند افسردگي و اختلالات اضطرابي .
- مشكل اساسي نشان دادن ارتباط بين استرس و بيماري در مشخص كردن مسيرهاي روانشناختي يا فيزيولوژيكي نهفته بين آنها .

## نقش دستگاه ايمني در استرس :

- در الگوي سليه يكي از پيامدهاي استرس ، سركوبي دستگاه ايمني است . لوكوسيت ها ( گلبول هاي سفيد خون ) تشكيل دهنده اساس جمعيت سلولي در دستگاه ايمني .

- استـرس و اداره آن بـالقوه است .
- استـرس شامل : عوامل فيـزيولوژيكي و عوامـل روانشناختي است . و اكنـون چالش بر سر آن است كه ارتباط بيشتري بين اينـها ايجـاد كنيم .
- تأثيرپذيري مقـابله با استـرس و درمـان آن به وسيلـه باورهاي مـا در مـورد علل استـرس

واژه هاي مـهم :

- مقابله ( coping ) : فرايند تلاش در اداره نيازهايي كه بعنوان محدود كننده يا زياده روي از منـابع شخصي ارزيابـي مي شود .
- الگوي باور سلامت ( health belief model ) : نظريه تغيير رفتار سلامت بر اساس درك خطراتي كه سلامت را تهديد مي كند و اثربخشي اعمالي كه مـوجب كـاهش اين خطرات مي شود .
- ارتقاي سلامت ( health promotion ) : فلسفه كلي كه باور دارد سلامت دستـاورد جمعي و شخصي است و بـا ابتكار فردي ، اجتماعـي يا سياسـي حاصل مـي شود .

- درماندگي ( helplessness ) : باور به اينكه شخص قادر به تـأثير بـر محيط و تغييـر آن نيست كه در سـلامت شخصي نـقش دارد .
- منبـع كنتـرل ( locus of control ) : اعتقـاد به اينكه رويـدادهاي سلامت توسط خود شخص(دروني) يا محيط (بيروني) كنترل مي شوند.
- كيفيت زنـدگي ( quality of life ) : درجـه اي كه شخـص قـادر است عملكرد جسمي ، روانشناختي ، شغلي و اجتماعي خود را تا آن حد بالا ببرد .
- تصور از خـود ( self-image ) : مجمـوعه بـاورهاي يكپـارچه در مـورد كيفيت ها و اسنـادهاي خويـش .

- خودکـارآمدي ( self-efficacy ) : ادراکـي که شخص قـادر است عمل ويـژه اي را انجـام دهد .
- حمايت اجتماعي ( social support ) : اطلاعات از جـانب ديگران مبني بر مورد محبت / توجه / احترام و ارزش و بخشي از شبکه ارتباط و تعهد اجتماعـي بودن .
- استرس/ تنيدگي( stress ) : حالتي که به هنگام روبرو شدن افـراد با رويدادهاي تهديدکننده بـهزيستي جسمي يا روانشناختـي فرد بوجـود مي آيد ، رويـداد تهديدکننـده ، استـرسور يا تنيدگي زا است .

- سرسختي hardiness
- روانشناسي سلامت health psychology
- درماندگي آموخته شده learned helplessness
- سبك زندگي life style
- پيشگيري prevention
- اداره استرس stress management
- آسيب پذيري susceptibility
- آموزش تنش زدايي relaxation training